КЛИНИЧЕСКИЙ КОМПАС

Дневник-конструктор пациента

Полное функциональное и визуальное техническое задание: структура модулей, измерения, два кабинета, библиотека материалов, уведомления и сценарии безопасности.

Для кого подготовлен документ

Разработчик интерфейса и логики конструктора; продуктовая команда; врач-психиатр, психотерапевт, психолог; участники конкурсной демоверсии.

Часть I. Логика продукта

Первое знакомство, выбор целей, согласование плана, роли пациента и специалиста.

Часть II. Библиотека модулей

Разделы дневника с детализацией каждого измерения, частотой, типом ответа и цветом.

Часть III. Использование в лечении

Лекарства, питание, менструальный цикл, витамины, рекомендации, графики и безопасность.

Часть IV. Уведомления и макеты

Все предоставленные тексты уведомлений, реакция на события, стикеры и визуальные примеры.

Версия: 21 октября 2026 года. Основа: два приложенных проекта концепции, сообщение с библиотекой уведомлений и пользовательские визуальные референсы.

Статус: проектное ТЗ и иллюстративные макеты; не утверждённый клинический протокол и не готовая система медицинских рекомендаций.

Навигатор документа

- 01 • Идея, границы продукта и источники структуры
- 02 • «Окно доверия» и девять шагов знакомства с пациентом
- 03 • Откуда берутся категории и как врач собирает дневник
- 04 • Полная библиотека модулей и измерений: 18 цветовых разделов
- 05 • Ежедневный сценарий и отдельные экраны пациента / специалиста
- 06 • Питание, менструальный цикл, витамины, препараты, симптомы
- 07 • Библиотека материалов, задания и подготовка к консультации
- 08 • Отчёты, прогресс, шкалы, метаданные и безопасность
- 09 • Библиотека уведомлений: 10 групп и все тексты
- 10 • Правила стикеров, MVP и сквозная демонстрация
- 11 • Визуальное приложение: четыре подготовленных макета

Как читать документ

В каждой карточке библиотеки указаны: назначение, цвет, отдельные показатели, способ измерения, предлагаемая частота, место в интерфейсе и ограничения. Частота — проектное значение по умолчанию, которое специалист вправе изменить.

1. Концепция и границы

«Клинический компас» — модульная система наблюдения, которая помогает пациенту фиксировать самочувствие, повседневные трудности, действия по плану лечения и вопросы для специалиста. Дневник не должен быть одинаковым для всех: исходные модули определяются выбранными пациентом целями, анамнезом, актуальными жалобами и подтверждённым специалистом планом наблюдения.

Четыре задачи системы: (1) показывать изменения состояния во времени; (2) наблюдать выполнение и переносимость назначенного лечения; (3) фиксировать изменения повседневного функционирования; (4) отображать достижение индивидуальных целей, не подменяя их условным «процентом выздоровления».

Какие идеи берём из референсов

Источник / визуальный принцип	Как адаптируем для «Компаса»
Bearable, экраны 21–31 предоставленной подборки	Вопросы «зачем вы здесь», цели, симптомы, факторы, привычки и желаемые отслеживания — перед индивидуальной настройкой.
Apple Health, каталог показателей	Единая библиотека разделов: питание, лабораторные и физиологические показатели, лекарства, витамины, антропометрия; на главной видны только выбранные.
Стикеры-коты и тематические иконки	Коты — только пациентские мягкие уведомления и иногда прогресс. Врачебный кабинет — строго без котов. Силуэт — ориентир антропометрии.
Пользовательские графики и карточки	У пациента — простые цветные карточки и личные цели. У специалиста — исходные данные, разные шкалы, пропуски, симптомы, клиническая безопасность.

Научная логика — без смешения методов

Механизм	Назначение	Пример
EMA / короткие записи	Повседневные колебания состояния	Настроение и тревога 0–10, сон и энергия.
MBC / стандартизированные шкалы	Оценка выраженности симптомов на контрольных точках	PHQ-9, GAD-7 по правилам выбранных методик.
ROM / цели и функционирование	Повседневная жизнь и эффект помощи	WSAS, индивидуальные цели, выполнение осмысленных действий.

Принцип: дневниковая тревога 0–10 не равна GAD-7 0–21, а оценка цели 6/10 не означает «выздоровел на 60%». Высокая энергия также не всегда означает улучшение. Все сравнения должны быть привязаны к одному способу измерения и интервалу времени.

2. Первое знакомство: «Окно доверия»

Текст первого экрана

«Иногда бывает трудно сразу описать, что с нами происходит. Этот дневник поможет замечать изменения в самочувствии и подготовиться к разговору со специалистом. Вы можете выбрать темы, о которых готовы рассказывать; специалист предложит показатели, важные для наблюдения. Необязательные вопросы можно пропустить или отложить». Кнопки: «Начать» / «Как используются мои данные?» / «Можно ли пропускать вопросы?».

До первых чувствительных вопросов следует понятно разъяснить: кто видит записи; когда специалист просматривает их; какие сообщения не являются экстренной связью; когда возможна передача информации ради безопасности; как управлять согласием, хранением и удалением данных. Нельзя обещать абсолютную конфиденциальность или круглосуточную реакцию врача.

Последовательность персонализации (9 экранов)

Шаг	Вопрос / примеры	Поведение системы
Экран 1 · Почему вы здесь?	«Что вам сейчас хотелось бы лучше понимать?» Примеры: Изменения настроения; тревогу; сон; энергию; влияние лекарств; самочувствие тела; питание; выполнение рекомендаций; подготовку к приёму; пока не знаю.	Несколько вариантов; «другое» и «пропустить». Никаких диагностических выводов.
Экран 2 · Ваша главная цель	«Что хотелось бы изменить в ближайшие недели?» Примеры: Лучше спать; легче справляться с тревогой; вернуться к занятиям; замечать побочные эффекты; понять, что влияет на настроение; выполнять план лечения.	Выбрать 1–3 приоритета; свободный ответ; последующая оценка цели 0–10.
Экран 3 · Что происходит сейчас?	«Какие трудности вы замечаете чаще всего?» Примеры: Тревога; усталость; сонливость; бессонница; перепады настроения; трудности концентрации; сниженный интерес; головная боль; другое.	Симптомы — самостоятельные жалобы, не диагноз; отслеживание по выбору.
Экран 4 · Что хотите отслеживать?	«Какие разделы добавить в ваш дневник?» Примеры: Эмоции; сон; препараты; питание и вода; активность; самочувствие тела; измерения; рекомендации; цели; другое.	Не показывать все подробные параметры; свернуть подкатегории.
Экран 5 · Факторы и привычки	«Что может быть связано с изменениями вашего состояния?» Примеры: Учёба/работа; стресс; физическая активность; кофеин; алкоголь; общение; дневной сон; экранное время; питание; событие.	Показывать возможные связи в дневнике без вывода «причина найдена».
Экран 6 · Лекарства и добавки	«Вы сейчас принимаете лекарства, витамины или другие добавки?» Примеры: Назначенные препараты; препараты по необходимости; витамины/минералы по назначению; БАДы по собственной инициативе; ничего; не хочу указывать.	Запрашивать название, дозу, расписание, источник назначения; согласие на напоминания.
Экран 7 · Частота и удобство	«Когда удобнее отмечать состояние?» Примеры: Утром; вечером; утром и вечером; только после значимых событий; без напоминаний.	Рекомендованные врачом контрольные измерения отдельно; выбор «не знаю».
Экран 8 · Важное для обсуждения	«Есть что-то, о чём вам особенно важно рассказать специалисту?» Примеры: Свободный текст; голос; загрузка файла; «обсудить на приёме»; пропустить.	Чувствительные сведения отдельно, с прозрачными правами доступа.
Экран 9 · Согласование	«Ваш дневник готов к согласованию» Примеры: Показать выбранные пациентом разделы; добавленные специалистом; время заполнения; план повторных шкал.	Пациент видит, что обязательно по плану и что можно скрыть/отложить.

После знакомства

Система формирует предварительный дневник из пожеланий пациента. Затем специалист проверяет его, добавляет необходимые клинические измерения, настраивает частоту, обязательность и ограничения доступа. Пациент видит, что добавлено врачом, а что выбрал сам.

3. Как формируется дневник-конструктор

Источники категорий должны быть явными: диагноз или ведущий запрос; жалобы и симптомы; назначенные препараты и их профиль нежелательных реакций; цели и предпочтения пациента; возраст и другие актуальные индивидуальные факторы; клиническое решение специалиста. Ни один источник сам по себе не означает автоматическую постановку диагноза.

Источник	Что добавляет в конструктор	Ограничение
Задача / диагноз, подтверждённый специалистом	Релевантные модули и контрольные шкалы.	Не ставить диагноз по ответам автоматически.
Текущие жалобы	Конкретные симптомы, частота, выраженность, динамика.	Симптом — не причина и не диагноз.
Схема терапии	Отметка приёма; выборочные вопросы о переносимости; безопасность.	Назначения подтверждает уполномоченный врач.
Цели пациента	Индивидуальная шкала прогресса и важные для него действия.	Цели не замещают обязательный мониторинг.
Особенности и предпочтения	Цикл, питание, доступность ответов, удобное время.	Чувствительные блоки — добровольно и с настройками доступа.
Профессиональная настройка	Частота, условные ветки, контрольные точки и критические события.	Автоматическое назначение исключено.

Операция настройки специалистом

- 1. Выбрать пациенту стартовый шаблон: например, «тревога + депрессивные симптомы + лекарственная терапия».
- 2. Открыть каталог модулей и выбрать нужные категории/подкатегории/конкретные показатели; доступен поиск по медицинским и разговорным синонимам.
- 3. Настроить каждый показатель: формулировка, тип ввода, единицы, границы шкалы, частота, возможность пропуска, условия уточняющих вопросов.
- 4. Настроить права доступа для чувствительных комментариев, файлов, цикла и сексуального здоровья.
- 5. Назначить контрольные шкалы, материалы и задания с датами; выбрать отчётные показатели.
- 6. Посмотреть предварительный вариант глазами пациента с ожидаемым временем заполнения; согласовать план.
- 7. Вести версии плана и шкал. При изменении вопросов/границ не сравнивать результаты без отметки о версии.

Пример плана на 1–2 минуты

Каждый день: настроение 0–10, тревога 0–10, сон, энергия, факт приёма лекарств. По событию: новые симптомы, стресс, комментарий. На назначенных контрольных точках: PHQ-9/GAD-7 и функционирование. Отдельно: материалы и упражнения.

4. Полная библиотека модулей и показателей

Ниже — проектный каталог, составленный преимущественно из загруженного подробного описания показателей и расширенный по твоим новым требованиям. Категории доступны через экран «Каталог модулей»; в план конкретного пациента попадают только выбранные и согласованные элементы. Цвет закрепляется за категорией, но не обозначает хорошее или плохое самочувствие.

Для каждой записи в технической базе должны храниться название, тип измерения, единица, крайние подписи шкалы, частота, роль инициатора, правила пропуска, версия формулировки, дата и источник. В таблицах указаны значения для планирования интерфейса; это не универсальный медицинский норматив.

01. Общее самочувствие

Назначение: Быстрый необязательный вход: что происходит сейчас и что хочется сохранить.

Показатель	Как измеряется	Рекомендуемая частота
Общая оценка состояния	Шкала 0–10 с подписанными крайними значениями	Короткий чек-ин по плану
Самое заметное за день	Один вариант: событие / мысль / чувство / другое	По желанию
Как изменился день	Лучше / так же / хуже привычного, «трудно сказать»	По желанию
Свободная заметка	Текст, голос, «нет подходящего ответа»	По желанию

02. Эмоциональное состояние

Назначение: Настроение, тревога, ангедония, энергия, раздражительность, эмоции, панические эпизоды.

Показатель	Способ измерения	Частота
Общее настроение	Шкала 1–10 с фиксированными описаниями	Ежедневно
Эмоциональная окраска	Семь категорий от очень неприятного до очень приятного	Ежедневно
Конкретные эмоции	Выбор: грусть, радость, страх, злость, спокойствие и др.	Ежедневно, по желанию
Тревога	0–10: от отсутствия до максимально выраженной	Ежедневно
Ангедония	0–10: насколько трудно испытывать удовольствие	Ежедневно при депрессии
Энергия	0–10: от выраженной нехватки до избытка энергии	Ежедневно
Усталость	0–10: насколько выражена усталость	Ежедневно
Раздражительность	0–10 либо частота эпизодов	По показаниям
Внутреннее напряжение	0–10	По показаниям

Показатель	Способ измерения	Частота
Безнадёжность	0–10 с клинически согласованной формулировкой	По показаниям
Уверенность в себе	0–10	По индивидуальному плану
Эмоциональные перепады	Количество/факты эпизодов, длительность	По показаниям
Панические атаки	Количество, продолжительность, интенсивность	По событию
Чувство одиночества	0–10	По индивидуальному плану
Чувство контроля над ситуацией	0–10	По индивидуальному плану

Отчёт: отдельные линии настроения, тревоги и энергии; отдельное распределение эмоций и частота приступов. Высокий балл настроения сам по себе не доказывает клиническое улучшение.

03. Сон и биологические ритмы

Назначение: Режим, длительность и качество сна; сонливость и восстановление.

Показатель	Измерение	Частота
Время отхода ко сну	Часы и минуты	Ежедневно
Время пробуждения	Часы и минуты	Ежедневно
Продолжительность сна	Часы и минуты	Ежедневно
Время засыпания	Минуты	При нарушениях сна
Ночные пробуждения	Количество	По показаниям
Время бодрствования ночью	Минуты	По показаниям
Качество сна	Оценка 1–5	Ежедневно
Восстановленность после сна	0–10	Ежедневно
Дневная сонливость	0–10	По показаниям
Дневной сон	Продолжительность в минутах	По показаниям
Кошмары	Факт и количество	По показаниям
Уменьшение потребности во сне	Да/нет и связь с повышением энергии	При риске гипомании

Уточнение: продолжительность сна не равна времени в постели; записывать дату ночи и корректировать смену суток.

04. Повседневная активность

Назначение: Учёба, работа, бытовые дела, общение, шаги, избегание, функционирование.

Показатель	Измерение	Частота
Посещение работы или учёбы	Да/нет, часы, пропуски	Ежедневно при необходимости
Способность выполнять задачи	0–10	По показаниям
Бытовая активность	Чек-лист выполненных действий	Ежедневно
Самообслуживание	Чек-лист или степень затруднений	По показаниям
Социальные контакты	Количество либо факт общения	По показаниям
Социальная изоляция	0–10 или количество дней	По показаниям
Выход из дома	Да/нет, частота	По индивидуальному плану
Физическая активность	Минуты, вид деятельности	По плану
Количество шагов	Шаги/день, при согласии на импорт	Автоматически/вручную
Приятные занятия	Количество, вид и полученное удовольствие	Ежедневно при депрессии
Избегающее поведение	Частота ситуаций избегания	При тревожных расстройствах
Уровень самостоятельности	Индивидуальная шкала/чек-лист	Периодически
Социальное и профессиональное функционирование	WSAS 0–40	На контрольных точках

Результат: не только количество шагов. Важно, вернулся ли человек к значимым бытовым и социальным действиям.

05. Когнитивные функции

Назначение: Память, внимание, принятие решений, навязчивые мысли и действия по показаниям.

Показатель	Измерение	Частота
Концентрация внимания	0–10, степень затруднений	По показаниям
Субъективная память	0–10 либо отмеченные эпизоды	По показаниям
Принятие решений	Степень затруднения 0–10	По показаниям
Умственная утомляемость	0–10	По показаниям
Замедленность мышления	Субъективная оценка, клиническое наблюдение	По показаниям
Навязчивые мысли	Частота, длительность, влияние на функционирование	При соответствующем расстройстве
Компульсивные действия	Количество или затраченное время	При ОКР
Выполнение задач на внимание	Результат стандартизированного теста	По назначению

06. Медикаментозная терапия

Назначение: Назначения, фактический приём, пропуски и переносимость; история изменений.

Показатель	Измерение	Частота
Назначенный препарат	Действующее вещество, форма, доза	При назначении и изменении
Время приёма	Время фактического приёма	При каждом приёме
Выполнение назначения	Принят/пропущен/отложен	По схеме
Количество принятых доз	Число доз относительно назначенных	По схеме
Причина пропуска	Выбор причины или комментарий	По событию
Изменение дозировки	Дата, старая и новая доза, назначивший врач	По событию
Новый симптом после назначения	Вид, дата появления	По событию
Выраженность побочного эффекта	0–4 либо 0–10 с фиксированными якорями	По событию
Частота побочного эффекта	Эпизоды за период	По показаниям
Длительность побочного эффекта	Минуты, часы, дни	По событию
Влияние побочного эффекта на жизнь	Шкала и/или FIBSER	При контрольной оценке
Субъективная переносимость	0–10	На контрольных точках
Причины желания изменить лечение	Выбор и свободный комментарий	По необходимости

Ключевое различие: отсутствие отметки — «нет данных», а не доказанный пропуск лекарства. Отмена, замена и изменение дозы возможны только по решению врача.

07. Антропометрические показатели

Назначение: Масса, рост, окружности и производные значения, при необходимости без показа веса пациенту.

Показатель	Измерение	Частота
Рост	Сантиметры	При регистрации, затем по показаниям
Масса тела	Килограммы	По назначению, часто не ежедневно
Индекс массы тела	кг/м², рассчитывается из массы и роста	При наличии данных
Изменение массы	Кг и % относительно исходного значения	Автоматический расчёт
Окружность талии	Сантиметры	По показаниям
Окружность бёдер	Сантиметры	По показаниям

Показатель	Измерение	Частота
Соотношение талии и бёдер	Расчётный показатель	По показаниям
Скорость изменения массы	Кг за выбранный период	При динамическом контроле

Пиктограмма: нейтральный силуэт без лица. Массу и ИМТ нельзя автоматически окрашивать «хорошо/плохо». Для несовершеннолетних используются соответствующие возрастные подходы; при РПП врач может скрывать цифры.

08. Физиологические показатели

Назначение: АД, пульс, температура, глюкоза, лабораторные значения и обследования.

Показатель	Измерение	Частота
Артериальное давление	Систолическое/диастолическое, мм рт. ст.	По показаниям
Частота сердечных сокращений	Уд/мин	По показаниям
Пульс в покое	Уд/мин	По показаниям
Ортостатические изменения	АД/ЧСС в стандартных условиях	По назначению
Температура тела	°C	По показаниям
Вариабельность сердечного ритма	мс, с указанием метода и устройства	Дополнительный показатель
Сатурация	SpO_2, %	По показаниям
Уровень глюкозы	ммоль/л	По назначению
HbA1c	% или ммоль/моль	В установленные сроки
Липидный профиль	Лабораторные значения	По назначению
ЭКГ / QTc	Результат клинического исследования	По назначению
Другие лабораторные данные	Результат, единицы, дата, референс	По назначению

09. Питание и вода

Назначение: Аппетит, регулярность, связь с эмоциями, вода, кофеин; расширение без навязчивых подсчётов.

Показатель	Как измеряется	Рекомендуемая частота
Аппетит	0–10 либо ниже/обычно/выше привычного	По назначению
Регулярность питания	Количество приёмов пищи; при необходимости время	По плану
Питание на фоне эмоций	Нет / больше обычного / меньше обычного / трудно сказать	По желанию
Предшествующие события	Стресс / усталость / скука / радость / другое	По событию
Голод/насыщение	Категориальная оценка без обязательного подсчёта калорий	Если необходимо

Показатель	Как измеряется	Рекомендуемая частота
Вода	Миллилитры или стаканы с заданным объёмом; не считать 5 стаканов нормой	По желанию
Кофеин	Порции кофе/чая, тип и при необходимости время	При отслеживании
Подробный рацион	Текст/фото и нутриенты при обоснованном назначении	Дополнительный режим

Пищевой режим по умолчанию не должен поощрять подсчёт калорий. Фото рациона и нутриенты подключаются только при ясной цели, согласии и медицинском обосновании.

10. Соматическое самочувствие

Назначение: Телесные жалобы и симптомы по системам органов, дата появления, локализация.

Показатель	Измерение	Частота
Аппетит	0–10 либо уменьшен/обычный/повышен	По показаниям
Регулярность питания	Количество приёмов пищи	По показаниям
Потребление воды	мл или литры	По индивидуальному плану
Тошнота	0–4, эпизоды	По событию
Рвота	Количество эпизодов	По событию
Запор	Частота стула, характер жалоб	По показаниям
Диарея	Частота стула	По событию
Форма стула	Бристольская шкала 1–7	По показаниям
Боль	Локализация, интенсивность 0–10, длительность	По событию
Головная боль	Интенсивность, длительность, частота	По показаниям
Головокружение	Частота, выраженность	По показаниям
Тремор	Наличие, обстоятельства, выраженность	По показаниям
Потливость	Выраженность, обстоятельства	По показаниям
Сексуальные побочные эффекты	Выбор симптомов, субъективное влияние	Добровольно, по показаниям
Менструальный цикл	Даты и симптомы	Добровольно, по показаниям
Алкоголь, никотин и другие вещества	Факт, количество, частота; валидизированный скрининг при необходимости	По клинической необходимости

Запись о необычных выделениях, боли, сыпи и других симптомах — самостоятельная жалоба; она не становится «побочкой» только потому, что совпала с датой начала препарата.

11. Психотерапия и стрессовые события

Назначение: События, автоматические мысли, реакции, навыки и психотерапевтическая работа.

Показатель	Измерение	Частота
Значимые события	Краткая запись, категория события	По событию
Субъективный стресс	0–10	По индивидуальному плану
Автоматические мысли	Свободный текст, структурированная запись КПТ	По заданию
Эмоциональная реакция	Вид и интенсивность	По событию
Поведенческая реакция	Выбор действия и описание	По событию
Избегание	Факт, количество ситуаций	По показаниям
Выполнение домашнего задания	Выполнено/частично/не выполнено	По расписанию
Терапевтические навыки	Какой навык применён	По событию
Полезность навыка	0–10, субъективная оценка	По событию
Экспозиционное упражнение	Выполнено/не выполнено, длительность, тревога до и после	По заданию
Поведенческая активация	Запланированные и выполненные действия	По заданию
Достижение индивидуальной цели	Оценка 0–10	Периодически
Важное для обсуждения	Текст, голос, отметка «обсудить»	По желанию

12. Менструальный цикл

Назначение: Отдельный добровольный календарь и симптомы при менструациях, включая изменения настроения.

Показатель	Как измеряется	Рекомендуемая частота
Начало и окончание менструации	Календарные даты, подтверждённые пациентом	По событию
Продолжительность цикла	Число дней между первыми днями менструаций	Автоматически при данных
Продолжительность кровотечения	Число дней	По событию
Интенсивность кровотечения	Лёгкая / умеренная / обильная; не клинический объём без доп. методики	Во время менструации
Менструальная боль	0–10 + локализация + влияние на жизнь	По необходимости
Предменструальные симптомы	Отдельные симптомы, тяжесть, день цикла	По желанию
Настроение, тревога, сон	Связать имеющиеся записи с датами цикла, не заявлять причинность	По желанию
Необычные выделения	Локализация, цвет/запах по описанию, начало, боль/зуд/температура, фото — только добровольно	По событию

Показатель	Как измеряется	Рекомендуемая частота
Беременность/контрацепция	Отдельные чувствительные поля при согласии	По необходимости

Нельзя автоматически считать фазу цикла достоверной по одному календарному дню: например, день 14 не обязательно означает определённую фазу. Раздел подключается добровольно, независимо от гендерной идентичности и только если релевантен человеку.

13. Витамины, минералы и БАДы

Назначение: Отдельный список добавок и назначения, дозы, источник, переносимость.

Показатель	Как измеряется	Рекомендуемая частота
Название и состав	Точное название, активные вещества, концентрация, форма	При добавлении
Источник	Назначено врачом / собственная инициатива / не помню	При добавлении
Доза и схема	Мг, мкг, МЕ или другие правильные единицы; время и частота	При добавлении
Фактический приём	Принял / позже / пропустил / не помню	По схеме
Нежелательные симптомы	Отдельная связка с дневником симптомов, не причинно-следственный вывод	По событию
Результаты анализов	Число, единицы, дата, лаборатория и референс при показаниях	По назначению
Нутриенты из еды	Расчёт только при достоверном составе продукта и источнике	Расширенный режим

Не смешивать дозу добавки, количество нутриента в пище и лабораторную концентрацию. Это три разных типа данных.

14. Индивидуальные цели

Назначение: До трёх согласованных целей с базовым и повторным измерением по GBO-подобному принципу.

Показатель	Как измеряется	Рекомендуемая частота
Цель	Описанная пациентом и согласованная со специалистом	При составлении плана
Исходное значение	0–10 с фиксированной интерпретацией достижения цели	В начале
Текущее продвижение	0–10 по той же шкале; дата оценки	Еженедельно/по плану
Запланированное действие	Чек-лист, дата и конкретный шаг	По индивидуальному плану
Факт выполнения	Да / частично / нет; комментарий без оценки личности	По событию
Маленькая победа	Текст/голос; не обязательно	По желанию

15. Клинические шкалы

Назначение: Контрольные стандартизированные инструменты отдельно от повседневного опроса.

Показатель	Как измеряется	Рекомендуемая частота
PHQ-9	9 пунктов; баллы 0–27 по утверждённым правилам	На назначенных контрольных точках
GAD-7	7 пунктов; баллы 0–21 по утверждённым правилам	На назначенных контрольных точках
WSAS	Функционирование 0–40 по правилам методики	На контрольных точках
WHO-5 / ISI	Отдельные методики со своими периодами и правилами подсчёта	По клинической задаче
MADRS / YMRS	Врачебные оценки; не обычный ежедневный самоопрос	По назначению специалиста
FIBSER	Частота, интенсивность и влияние побочных явлений	Если используется врачом

Перед внедрением необходимы проверка актуальной версии и лицензии, правила подсчёта и роль ответственного специалиста. PHQ-9 и GAD-7 не нужно проходить ежедневно по умолчанию.

16. Материалы и рекомендации

Назначение: Назначенные статьи, видео, упражнения и обратная связь об их использовании.

Показатель	Как измеряется	Рекомендуемая частота
Назначенный материал	Статья, видео, памятка, упражнение, чек-лист, ссылка	По назначению
Статус	Не открывал / открыл / ознакомился / попробовал / частично / выполнил	При взаимодействии
Понятность и полезность	Категория или шкала 0–10 при необходимости	После материала
Причина затруднения	Не понял / нет сил / не подошло / другое + комментарий	Если не выполнено
Вопрос для врача	Флажок «хочу обсудить»; текст или голос	По желанию

17. Подготовка к консультации

Назначение: Отметки для обсуждения, голос, файлы, вопросы и резюме.

Показатель	Как измеряется	Рекомендуемая частота
Что обсудить	Текст / голос + флажок «обсудить»	По желанию
Событие и дата	Календарь, краткая категория	По событию
Файлы	PDF / изображение / документ при явном согласии	По необходимости
Сводка состояния	Контрольные значения и даты, без автоматического диагноза	Перед визитом

Показатель	Как измеряется	Рекомендуемая частота
Список вопросов	Ручное ранжирование пациентом важных тем	Перед визитом

18. Специализированные модули

Назначение: Под диагноз или клиническую задачу: панические эпизоды, ПТСР, ОКР и др.; подключает специалист.

Специализированный модуль	Примеры измеряемых параметров
Биполярное расстройство	Эпизоды повышенного настроения, раздражительность, сон, изменение потребности во сне, импульсивность, активность
Паническое расстройство	Количество приступов, длительность, избегание, страх повторного приступа
Социальная тревожность	Ситуации избегания, выраженность тревоги, участие в общении
Обсессивно-компульсивные симптомы	Время на обсессии/компульсии, влияние на жизнь
ПТСР	Флешбэки, кошмары, избегание, гипервозбуждение
Расстройства пищевого поведения	Пищевое поведение, симптомы, медицинский контроль по специальному протоколу
Психотические расстройства	Симптомы, сон, функционирование, переносимость терапии, клинически согласованные предвестники обострения
СДВГ	Внимание, организация задач, импульсивность, функционирование
Хроническая боль	Интенсивность, длительность, влияние боли на деятельность
Нарушения сна	Дневник сна, бессонница, дневная сонливость
Употребление психоактивных веществ	Частота, количество, тяга, ситуации риска
Индивидуальное хроническое заболевание	Связанные симптомы и медицинские показатели по назначению врача

Шкала	Что оценивает	Диапазо
PHQ-9	Депрессивные симптомы за две недели	0–27
GAD-7	Тревожные симптомы за две недели	0–21
QIDS-SR16	Депрессивная симптоматика за неделю	0–27
WHO-5	Психологическое благополучие за две недели	0–25, ли
WSAS	Влияние проблемы на функционирование	0–40
ISI	Выраженность бессонницы	0–28
PCL-5	Симптомы ПТСР	0–80
OCI-R	Обсессивно-компульсивная симптоматика	0–72

Специализированный модуль	Примеры измеряемых параметров	
PDSS	Тяжесть панических симптомов	Зависит
MADRS	Тяжесть депрессии, оценка специалиста	0–60
YMRS	Маниакальные симптомы, оценка специалиста	0–60
FIBSER	Частота, интенсивность, влияние побочных эффектов	Три отд
Goal-Based Outcomes (GBO)	Прогресс по персональным целям	0–10 дл
Категория	Основные графики	
Эмоции	Линейные графики настроения, тревоги, энергии; распределение эмоций	
Сон	Продолжительность сна, время засыпания, качество сна, стабильность режима	
Активность	Количество выполненных действий, активные дни, выполнение индивидуальных целей	
Лекарства	Календарь приёма, изменения доз, временная шкала побочных эффектов	
Антропометрия	Динамика массы тела, окружности талии и других назначенных измерений	
Физиология	Линейные графики АД, ЧСС, лабораторных показателей	
Соматические симптомы	Частота, выраженность и продолжительность симптомов	
Психотерапия	Выполнение заданий, избегание, субъективный прогресс	
Клинические шкалы	Изменение суммарных баллов и клинически интерпретируемых результатов	

Предложение подключить клинический модуль не означает автоматического заключения о заболевании.

5. Интерфейс пациента и ежедневный маршрут

Главная страница пациента — лёгкая, с персональными целями и количеством оставшихся коротких пунктов. Только на ней допускаются котики-стикеры: максимум один небольшой акцент на экране прогресса или в мягком напоминании, без визуального шума. Другие карточки используют тематические иконки и заданные цвета.

Зона	Что показывает	Поведение
Верх экрана	Сегодня, приветствие, короткий план, время до заполнения.	Кнопки «Заполнить», «Мне нужно сообщить», «Позже».
Карточки модулей	Настроение, сон, лекарства, питание, цели, цикл и другие только включённые модули.	Последнее значение + дата; можно изменить порядок и закрепить.
Мои цели	Постепенно возвращаться к занятиям, состояние конкретной цели (например, 6/10).	Показывать изменение цели, а не процент выздоровления.
История / прогресс	Личные графики и события за 7/14/30 дней.	Подписи, шкала, отсутствие данных и дата.
Материалы и рекомендации	Назначенные статьи, видео, памятки и упражнения.	Открыть / позже / попробовать / обсудить.
Комментарии	Свободный текст, голос, файл и флаг для специалиста.	Подтверждение отправки, права доступа, отсутствие обещаний немедленного ответа.

Ежедневный маршрут, 60–120 секунд в демо

- 1. Как проходит день? — Настроение и/или тревога по согласованным шкалам.
- 2. Как спалось? — Часы/минуты, качество; уточнения только при проблеме.
- 3. Как с энергией и повседневными делами? — 0–10 + одно значимое действие.
- 4. Удалось ли принять назначенные лекарства? — Статус по каждой назначенной дозе.
- 5. Появилось ли что-то необычное? — Нет / конкретный симптом / другое с уточнением.
- 6. Хотите что-то добавить? — Текст, голос, фото/файл и флаг «обсудить».

Не показывать длинный список симптомов и все модули сразу. Дополнительные вопросы появляются по условию, прогресс черновика сохраняется, «пропустить» и «продолжить позже» доступны по умолчанию.

Пример текстового расположения главной страницы пациента

Главная пациента — пример

МОЙ КОМПАС • Сегодня
«Как вы себя чувствуете? Можно начать с одной короткой записи».
Дневник на сегодня: 3 из 5 пунктов • [Продолжить] [Позже]
Эмоции 5,8/10 • Сон 7 ч 12 мин • Активность 3 из 4 • Лечение: 1 вопрос для обсуждения
Цикл (если включён) • Питание • Измерения тела [силуэт] • Рекомендации специалиста
Цель «Регулярно посещать занятия»: 6/10. Сравнение с исходной оценкой.

6. Интерфейс специалиста — отдельный, без котов

Профессиональный экран не повторяет эмоциональный дизайн пациента. Здесь нейтральная палитра, таблицы, клинические показатели, источники информации, пропуски и безопасность. Ни одного кота или анимированного персонажа. Данные пациента не должны заменяться «оценкой хорошего поведения».

Блок	Обязательно отображать
Исходные данные	Запрос, диагноз при подтверждении, дата начала наблюдения, назначенные шкалы, сопутствующие заболевания и лекарства.
Динамика	Отдельные графики PHQ-9, GAD-7, ежедневного настроения и тревоги; функционирование и цели.
Лечение	Назначения, версии схем, отметки приёма, новые симптомы, время и комментарии.
Нет данных	Не заполнено в назначенные дни; отдельно от подтверждённых пропусков приёма.
Сигналы внимания	Новые выраженные симптомы, изменения сна/тревоги, сообщения для обсуждения, результаты согласованных протоколов безопасности.
Рекомендации	Что назначено, открыто, попробовано, выполнено частично или вызвало затруднение.
Подготовка визита	Список вопросов, прикреплённые материалы, события, которые отметил пациент, кнопка создания отчёта.

У врача должна быть возможность открыть любой агрегат до исходной записи и увидеть дату, единицы, автора и версию измерения. Врачебный интерфейс позволяет менять план наблюдения с сохранением истории изменений. Предупреждения об опасных симптомах не должны зависеть от наличия котиков или игрового прогресса.

7. Специальные сценарии

7.1. Питание и вода

Базовая версия: регулярность еды, аппетит, связь еды с переживаниями, самочувствие после пищи. Дополнительная: когда ели, кофеин, вода, симптомы ЖКТ. Расширенная: состав рациона, отдельные нутриенты и фото исключительно по клиническому запросу и согласию.

Текст без стигмы

«Замечали ли вы, что эмоции сегодня влияли на желание поесть?»
Нет / Ел(а) больше обычного / Ел(а) меньше обычного / Трудно сказать.
«Что происходило перед этим?» — напряжение, усталость, скука, радость, другое.
«Хотите рассказать подробнее?» — текст или голос.

Не использовать «сорвался», «вредная еда» или наказание за несоблюдение плана. При риске РПП отключить калорийность, частые взвешивания и сравнение с другими. Любые значения «не заполнено» остаются пропуском данных, а не нулём.

7.2. Менструальный цикл

Дополнительный добровольный модуль: даты начала и окончания менструации; длина цикла; объём кровотечения в субъективных категориях; боли 0–10; связанные изменения сна, тревоги и настроения; при необходимости контрацепция. Врач решает, релевантен ли модуль. Не назначать его автоматически всем «женщинам» и не выводить фазу по одному дню цикла как установленный факт.

Для необычных выделений: отдельный симптом с временем начала, местом, описанием, связью с болью/зудом/температурой и возможностью добровольно приложить изображение. Фото интимной области — особо чувствительный файл: отдельное согласие, ограничение доступа, безопасное хранение и возможность удалить. Срочные признаки должны вести к соответствующему маршруту медицинской помощи.

7.3. Витамины, минералы, препараты и БАДы

В одном календаре приёма следует различать рецептурные назначения, витамины и минеральные препараты, БАДы, самостоятельный приём и эпизодически используемые средства. Для каждого: точное название, действующие вещества, форма, доза, единицы, назначивший, расписание, дата, отметка фактического приёма, комментарий и переносимость.

Лабораторные уровни, поступление нутриента из пищи и приём добавки не являются одним показателем. Система может показывать врачу информацию для проверки взаимодействий, но не диагностирует дефицит по одному пищевому чек-листу.

7.4. Лекарства и адаптивный мониторинг побочных эффектов

Сценарий	Данные / поведение
Назначение	Торговое название, МНН, форма, доза, способ, схема, даты, назначивший врач; история изменений.
Подтверждение приёма	Принял(а) вовремя / позже / пропустил(а) / отложил(а) / не помню. Отсутствие ответа = нет данных.
Напоминание	Показывается только с согласия пациента; нейтральный текст на заблокированном экране; нажатие открывает выбор статуса.
Пропуск	Можно выбрать причину и написать комментарий. Система не рекомендует удваивать дозу и не меняет схему.
Побочные эффекты	По назначенному препарату — вопросы о релевантных реакциях; список по ЖКТ, ЦНС, сну, ССС, коже и др. Можно добавить неизвестный симптом.
Уточнение симптома	Когда появился; выраженность 0–4; частота; длительность; мешает ли жизни; было ли до лечения; комментарий/голос/файл.
Дополнительные средства	Витамины, минералы, БАДы, безрецептурные и эпизодически принимаемые лекарства записываются отдельно для проверки взаимодействий.

Адаптивная цепочка на примере

«После начала терапии вы замечали тошноту?» — Да / Нет / Не уверен(а).
Если «Да»: «Когда началась?», «Как часто возникает?», «Насколько выражена?», «Мешает ли еде и обычным делам?», «Было ли это до лечения?»
Дополнения: комментарий, голос, файл, «обсудить со специалистом».
Запись фиксирует событие, но не устанавливает, что его вызвал препарат.

Библиотека симптомов для конструктора может включать группы ЖКТ, нервная система, сон, сердечно-сосудистая система, кожа, репродуктивная/сексуальная система и другие. Пациент сначала выбирает точный симптом внутри системы органов, например «ЖКТ → тошнота», а не отмечает «не хочу побочных эффектов ЖКТ» целиком.

Для потенциально опасных реакций — клинически утверждённый маршрут экстренного обращения. Приложение не меняет дозы, не советует самостоятельно прекращать препарат и не гарантирует круглосуточную проверку файлов врачом.

8. Библиотека материалов и рекомендации специалиста

Это отдельный профессиональный каталог статей, видео, памяток, упражнений, чек-листов и ссылок. Специалист может добавлять собственные проверенные материалы или отбирать материалы коллег; пациент видит назначенное в своём кабинете. Необходимо разделить «материал предложен коллегой» и «содержимое прошло проверку».

Объект	Что хранить / отображать
Материал в библиотеке	Название, тема/диагноз/цель, формат, возрастная аудитория, автор, ссылка или файл, дата публикации, дата проверки, доказательная основа, язык, права на использование.
Профессиональное качество	Статус «проверено редактором/клиническим экспертом», версия, замечания; предложенные коллегами материалы не становятся автоматически рекомендованными.
Назначение пациенту	Кто назначил, зачем, дедлайн при необходимости, инструкция, ожидаемое время, возможность «пока не готов(а)».
Статусы пациента	Не открывал(а); ознакомился(ась); попробовал(а); частично выполнил(а); не получилось; хочу обсудить.
Обратная связь	Понравилось / оказалось полезным (0–10); было непонятно; было тяжело; комментарий/голос.
Врачебный отчёт	Что было рекомендовано и когда; что пациент подтвердил; что вызвало трудности; без автоматической оценки «хороший/плохой пациент».

Пример карточки задания

«Как устроен цикл тревоги» • статья • около 5 минут.
Цель: замечать ситуации, запускающие тревогу.
[Открыть] [Посмотреть позже] [Не подходит сейчас]
После просмотра: «Удалось ознакомиться?» — Да / Частично / Нет.
«Что осталось непонятным?» — текст / голос / «обсудить на приёме».

Внутри библиотечной карточки: автор, название, тема/диагноз/цель, формат и продолжительность, возрастная группа, язык, ссылка или файл, источник, дата проверки, статус клинической экспертизы, доступность и права на распространение.

Врачебная сводка: не процент «послушности», а какие упражнения пациент попробовал, что оказалось сложным, почему он отказался, что отметил для обсуждения. Психологу не следует предоставлять интерфейс назначения рецептурных препаратов, если это выходит за пределы его компетенции.

9. Графики, шкалы и расчёт прогресса

Две модели прогресса: пациент видит изменения своих значимых показателей и целей; врач — стандартизированные шкалы, контекст, отсутствие данных и безопасность. Нельзя сводить разные показатели в единый «процент выздоровления».

Показатель	Отображение	Корректная интерпретация
Настроение / тревога	Линейный график по дням 0–10 + точки	Субъективная динамика на той же шкале.
PHQ-9 / GAD-7	Отдельные графики по датам назначенных оценок	Шкалы имеют разные диапазоны и временные окна.
Сон	Ночное время, часы, качество, регулярность	Не приравнивать время в кровати ко сну.
Цель пациента	Начальное / текущее 0–10 по одной цели	6/10 не означает 60% выздоровления.
Препараты	Календарь подтверждённых приёмов и симптомов	Нет отметки не равно «пропущено».
Питание, вес, цикл	Индивидуальные значения и даты	Не окрашивать изменения как позитивные без контекста.
Рекомендации	Назначено, попробовано, частично, сложности	Выполнение задания не равно доказанной эффективности терапии.

Указывать период сравнения (7, 14, 30 дней), пропуски, границы шкал и доступ к отдельной исходной записи. Если есть только 11 из 14 дней наблюдений, график не должен выдумывать значения за оставшиеся три дня.

10. Технические правила для реализации

Сущность	Нужные поля / поведение
Категория модуля	module_id, название, цвет, иконка, короткое описание, уровень доступа, версия.
Показатель	metric_id, question_text, input_type, unit, scale_anchors, recall_period, optionality, version.
Назначение в дневник	patient_plan_id, approved_by, active_from/to, frequency, time_window, branching_rules.
Измерение	value, timestamp, timezone, patient/source/device, draft/submitted, missing_reason.
Лекарство	substance, brand, dose, route, schedule, prescriber, confirmed_event, modification_history.
Симптом	symptom_id, organ_system, onset, severity, frequency, baseline_present, effect_on_functioning, notes.
Материал	material_id, author, source, rights, validation_status, format, assignment, completion_state.
Уведомление	trigger, title, body, category, priority, quiet_hours, snooze, opt_in, sensitive_preview.
Файл / голос	owner, uploader, consent, access_role, linked_entry, created_at, retention/deletion.
Безопасность	risk_event, verified_rule_version, display_action, escalation pathway, audit log.

Нужно различать «нет», «0», «пропущено», «неизвестно», «не применимо» и «не ответил». При каждом изменении шкалы хранить версию. Уведомления не должны показывать диагноз и название препарата на заблокированном экране без согласия.

Правила безопасности

Дневник не является каналом экстренной помощи и не заменяет клиническое решение. Для суицидальных мыслей и серьёзных соматических симптомов нужны утверждённые специалистами маршруты. Не выдавать вероятную причинную связь симптома с препаратом за установленную. Защищать интимные фото и голосовые сообщения.

Дизайн-спецификация. Цвета всех категорий и единый вид карточек

Ниже закреплены две отдельные величины для каждой категории: фон карточки и насыщенный цвет иконки/акцента. Программист должен хранить их как токены темы, чтобы одинаковые модули выглядели единообразно. На врачебном экране доминирует белый фон; цвет категории допустим только в легендах и небольших акцентах. Цвет никогда не является единственным признаком опасности или улучшения.

Категория	Фон HEX	Акцент HEX	Вид плитки в каталоге
Общее самочувствие	#EEE9FC	#8572D2	короткий чек-ин, значок диалога
Эмоциональное состояние	#FDE8F0	#DF679B	эмоция/мозг, настроение 0–10
Сон и биологические ритмы	#E8F2FF	#5C91D1	луна, часы сна
Повседневная активность	#E8F7EF	#4AA885	шаги и цели
Когнитивные функции	#F3EDFD	#8B78B7	внимание, концентрация
Медикаментозная терапия	#FFF0E5	#D48751	иконка лекарства и статусы
Антропометрические показатели	#F0EBFE	#8571BA	нейтральный силуэт без лица
Физиологические показатели	#E6F5F7	#4B9FA3	пульс/АД и единицы
Питание и вода	#FFF5D9	#D3A536	еда, аппетит, вода
Соматическое самочувствие	#E8F7F8	#55A5A5	системы органов и локализация
Психотерапия и стрессовые события	#E6F6F1	#6C9D91	события и практики
Менструальный цикл	#FCE4EE	#D96C9F	календарь и даты, добровольно
Витамины, минералы и БАДы	#F7F0DB	#BF974A	добавки и дозировки
Индивидуальные цели	#E8F7EF	#389C80	цель и конкретный прогресс
Клинические шкалы	#EEF1FC	#607FC1	опросники на контрольных точках
Материалы и рекомендации	#E6F0FF	#6593CB	книга/видео и статус
Подготовка к консультации	#E6F6F1	#74A48A	вопросы и файлы
Специализированные модули	#F1EBF6	#9D79AE	замкнутый клинический шаблон

Параметры карточек на экранах

Элемент	Техническое правило для макета
Карточка-категория пациента	Светлый фон из таблицы, акцентная пиктограмма, заголовок, последнее измерение/«нет данных», дата и стрелка. Отступы 16–20 px, скругление около 16 px (параметры демоверсии).
Главный экран пациента	Сетка 2 колонки при достаточной ширине; на узком экране — 1 колонка; порядок можно менять. Большие карточки не обязаны показываться все сразу.
Карточка ежедневного вопроса	Заголовок; короткая подсказка; поле ввода; «пропустить»; «комментарий», «голос» по желанию; индикатор времени. Без обязательного стикера.
Экран врача	Нейтральный фон; блок исходных данных, отдельные графики, таблица пропусков, лекарства, список обсуждения. Без котов на всех экранах специалиста.
График	Подписанные X/Y, единицы, фиксированный период, легенда, значок пропуска и контекстное открытие точек; нельзя полагаться только на цвет.
Стикеры котов	Только пациенту и выборочно: главным образом завершение записи, прогресс и мягкие уведомления. Нет в карточках критических рисков и на врачебных экранах.
Состояния кнопок	Управление клавиатурой и экранным диктором, контрастные подписи, минимальная зона касания ~44×44 px.

Палитра линий врачебных графиков

Настроение — синий #4B8BE8; тревога — зелёный #47A96B; качество сна — фиолетовый #9671C9. Разные шкалы/единицы — разные панели, даже если разделы принадлежат одному пациенту. Цвета — спецификация дизайна, не клинические пороги.

Дополнение А. Соматические жалобы: каталог по системам органов

Вместо одного длинного списка симптомов пациент открывает «Физическое самочувствие» → выбирает систему органов → конкретный симптом → отвечает на короткие уточнения. Это навигационная таксономия, не диагностический классификатор. Одно наблюдение может иметь несколько тегов, но хранится без дублирования. Например, «тошнота» доступна через ЖКТ и поиск.

Правило для всех симптомов

Поля по умолчанию: симптом, дата/время начала, локализация, интенсивность с подписанной шкалой (если применима), частота, длительность, был ли до лечения, влияние на повседневность, сопутствующие признаки, текст/голос/файл, «обсудить на приёме». Не следует ставить автоматический диагноз или считать жалобу доказанной побочной реакцией.

Экран	Внешний вид и поведение
Каталог систем	Плитки с пиктограммами органов, поиском по обычным словам и медицинским терминам; цвет общей категории #E8F7F8.
Подкатегория	Конкретные симптомы с чекбоксами. «Нет подходящего варианта» открывает свободный ввод. Можно отметить несколько.
Уточнение симптома	Новые вопросы появляются только по выбранному симптому; пользователь видит, зачем вопрос нужен, и может пропустить необязательное.
Врачебное резюме	Таблица «что/когда/как долго/тяжесть/сопутствует/изменение дозы/файл/комментарий». Нет котов.
Графики	Числовые оценки — линия во времени; события — точки/вертикальные маркеры; количество эпизодов — столбцы; доли отмеченных симптомов — таблица, а не ложный процент болезни.

А.1. ЖКТ — пищеварительная система

Пример вопроса пациенту: «Замечали ли вы тошноту? Когда она появилась? Насколько мешала есть или заниматься делами?»

Конкретный симптом	Как пациент вводит данные	Как выглядит динамика у специалиста
Тошнота	Наличие; 0–10 по согласованным якорям; время и длительность	Линия выраженности + маркеры возникновения
Рвота	Количество эпизодов за сутки; время, сопутствующие жалобы	Столбцы: эпизоды/сутки
Диарея / запор	Количество стула и дней; при необходимости Бристоль 1–7	Частота по дням; отдельная шкала типа стула
Боль в животе	Где болит, 0–10, длительность, связь со временем еды	Линия боли и события без вывода о причине
Аппетит / изжога / сухость во рту	Изменение аппетита, да/нет, частота; дополнительные поля	Раздельные серии только для сопоставимых оценок

Безопасность и ограничения: Кровь в рвоте/стуле, сильная боль, обезвоживание — не просто поле дневника: отдельная утверждённая ветка помощи.

A.2. Сердечно-сосудистая система

Пример вопроса пациенту: «Бывало ли учащённое сердцебиение? Сколько длился эпизод?»

Конкретный симптом	Как пациент вводит данные	Как выглядит динамика у специалиста
Сердцебиение	Да/нет, начало, продолжительность, обстоятельства	Число эпизодов по дням
Боль/дискомфорт в груди	Локализация, интенсивность, длительность, сопутствующие симптомы	Список событий и линия интенсивности
Головокружение при вставании	Да/нет, эпизоды; АД/ЧСС при назначении	Эпизоды + отдельные графики АД и ЧСС
Отёки	Локализация, дата появления, субъективное изменение	Хронология и периодические измерения

Безопасность и ограничения: Острая боль в груди, обморок, выраженная одышка требуют алгоритма срочной оценки, не удалённой самодиагностики.

A.3. Дыхательная система

Пример вопроса пациенту: «Было ли трудно дышать? Это происходило в покое или при движении?»

Конкретный симптом	Как пациент вводит данные	Как выглядит динамика у специалиста
Одышка	При нагрузке/в покое; начало, выраженность и обстоятельства	События + шкала тяжести по согласованному плану
Кашель	Сухой/с мокротой; частота, продолжительность	Дни с симптомом и число эпизодов
Свистящее дыхание	Да/нет, время, возможные обстоятельства	Хронология эпизодов
Температура / сатурация	°C, % SpO_2, прибор и дата — при показаниях	Отдельные линии с единицами и источником

Безопасность и ограничения: Остро возникшая сильная одышка или синюшность — маршрут экстренной помощи.

A.4. Неврологическая система

Пример вопроса пациенту: «Где именно ощущалась головная боль? Насколько выраженной она была?»

Конкретный симптом	Как пациент вводит данные	Как выглядит динамика у специалиста
Головная боль	0–10, локализация, часы, частота	Линия интенсивности и столбцы эпизодов
Тремор / подёргивания	Где, когда, как долго, влияние на движения	Календарь событий и субъективная тяжесть
Онемение / покалывание	Место на силуэте и продолжительность	Точки по дням + карта локализации

Конкретный симптом	Как пациент вводит данные	Как выглядит динамика у специалиста
Головокружение / нарушение координации	Эпизоды, длительность, контекст	Эпизоды/неделю, комментарии
Изменение зрения / речи	Начало, характер симптома, сопутствующие жалобы	Хронология, без автоматического диагноза

Безопасность и ограничения: Внезапные очаговые неврологические симптомы или необычайно сильная внезапная головная боль — срочный алгоритм.

A.5. Кожа и слизистые оболочки

Пример вопроса пациенту: «Появилась ли новая сыпь или зуд? Можно добавить фото, если вы согласны.»

Конкретный симптом	Как пациент вводит данные	Как выглядит динамика у специалиста
Сыпь / покраснение	Локализация на силуэте, дата появления, зуд	Хронология и карта расположения
Зуд	0–10, время, влияние на сон	Линия выраженности
Сухость кожи / слизистых	Да/нет, где, сколько дней	Дни с симптомом
Отёк лица / губ	Дата начала, сопутствующие признаки	Отдельное событие безопасности

Безопасность и ограничения: Отёк языка/губ с нарушением дыхания — маршрут срочной помощи; фотозаписи защищены.

A.6. Мочевыделительная система

Пример вопроса пациенту: «Есть ли дискомфорт при мочеиспускании? Когда начался?»

Конкретный симптом	Как пациент вводит данные	Как выглядит динамика у специалиста
Частота мочеиспускания	При необходимости количество эпизодов, изменение	Счётчик по суткам
Боль/жжение	Да/нет, 0–10, продолжительность	Линия выраженности
Изменение цвета/кровь	Описание, дата и сопутствующие признаки	Отдельное событие к оценке
Жажда / изменение объёма	Субъективно, по показаниям объём с единицами	Динамика по сопоставимым измерениям

Безопасность и ограничения: Кровь в моче, высокая температура с болью, острая задержка мочи — отдельные правила оценки.

A.7. Репродуктивная система и интимное здоровье

Пример вопроса пациенту: «Появились необычные выделения? Хотите описать их словами или добавить файл?»

Конкретный симптом	Как пациент вводит данные	Как выглядит динамика у специалиста
Необычные выделения	Источник/локализация, дата, цвет/запах — со слов, зуд, боль	Хронология без автоматического определения инфекции

Конкретный симптом	Как пациент вводит данные	Как выглядит динамика у специалиста
Боль внизу живота / тазу	0–10, локализация, длительность	Линия боли + цикл при согласии
Сексуальные изменения	Либидо, возбуждение, оргазм и другие жалобы добровольно	События / изменения по контрольным точкам
Кровотечение вне цикла	Дата, выраженность, сопутствующие признаки	Маркеры на календаре

Безопасность и ограничения: Интимные данные требуют отдельного согласия. Фото необязательно, доступ ограничен; сильное кровотечение и выраженная боль — отдельный маршрут.

A.8. Эндокринная и метаболическая система

Пример вопроса пациенту: «Заметили ли изменения потливости, жажды или ощущения температуры?»

Конкретный симптом	Как пациент вводит данные	Как выглядит динамика у специалиста
Жажда / потливость	0–10 или количество эпизодов	Субъективная шкала / дни
Ощущение холода / жары	Да/нет, время, длительность	Хронология
Аппетит и изменение массы	0–10, кг по датам; отдельный пищевой модуль	Линия массы; не по дням без смысла
Лабораторные показатели	ТТГ, глюкоза и пр. только по назначению с единицами и референсом	Точки лабораторных измерений

Безопасность и ограничения: Вопросы не заменяют оценку эндокринной патологии; без анализов не выводить «гормональный сбой».

A.9. Опорно-двигательная система

Пример вопроса пациенту: «Есть боль, скованность или дискомфорт в движении? Где именно?»

Конкретный симптом	Как пациент вводит данные	Как выглядит динамика у специалиста
Боль в мышцах / суставах	Место на силуэте, 0–10, длительность	Линия боли + карта локализации
Скованность	Минуты после пробуждения, выраженность	Продолжительность по дням
Ограничение движения	Какие действия затруднены, степень ограничения	Чек-лист функций по времени
Слабость	0–10, связь с нагрузкой по описанию	Динамика субъективной оценки

Безопасность и ограничения: Острая травма, сильная слабость с неврологическими признаками требуют отдельной оценки.

A.10. ЛОР и органы чувств

Пример вопроса пациенту: «Были ли необычные изменения слуха, зрения, вкуса или обоняния?»

Конкретный симптом	Как пациент вводит данные	Как выглядит динамика у специалиста
Звон в ушах	Есть/нет; постоянный или эпизодический; длительность	Дни/эпизоды
Боль в горле / носовая заложенность	0–10, длительность	Линия и события
Изменение слуха / зрения	Начало, внезапность, какие изменения	Хронология; в некоторых случаях срочная оценка
Изменение вкуса / обоняния	Да/нет, дата появления, выраженность	Дни с симптомом

Безопасность и ограничения: Внезапная потеря слуха или зрения — не рядовая запись для ожидания консультации.

A.11. Общие и инфекционные симптомы

Пример вопроса пациенту: «Была ли температура или выраженная слабость? Как это повлияло на день?»

Конкретный симптом	Как пациент вводит данные	Как выглядит динамика у специалиста
Температура	°C и источник/метод измерения	Линейный график температуры
Озноб / слабость	Да/нет, интенсивность 0–10	Календарь симптомов
Повышенная утомляемость	0–10 и влияние на дела	Линия выраженности
Изменение лимфатических узлов	Субъективное наблюдение, дата	Хронология, без самодиагностики

Безопасность и ограничения: Не выводить инфекционную этиологию только из чек-листа; опасные сочетания передавать в утверждённый алгоритм.

A.12. Общие симптомы, не подходящие под категорию

Пример вопроса пациенту: «Не нашли подходящего варианта? Опишите ощущение своими словами или голосом.»

Конкретный симптом	Как пациент вводит данные	Как выглядит динамика у специалиста
Новый необычный симптом	Произвольное описание + предложенные уточнения	Дата и связанный комментарий
Не знаю, как назвать	Выбор участка тела, собственные слова, голос	Отдельное событие, классификация — только при проверке
Хочу обсудить	Чекбокс, приоритет, контекст	Врачебный список вопросов

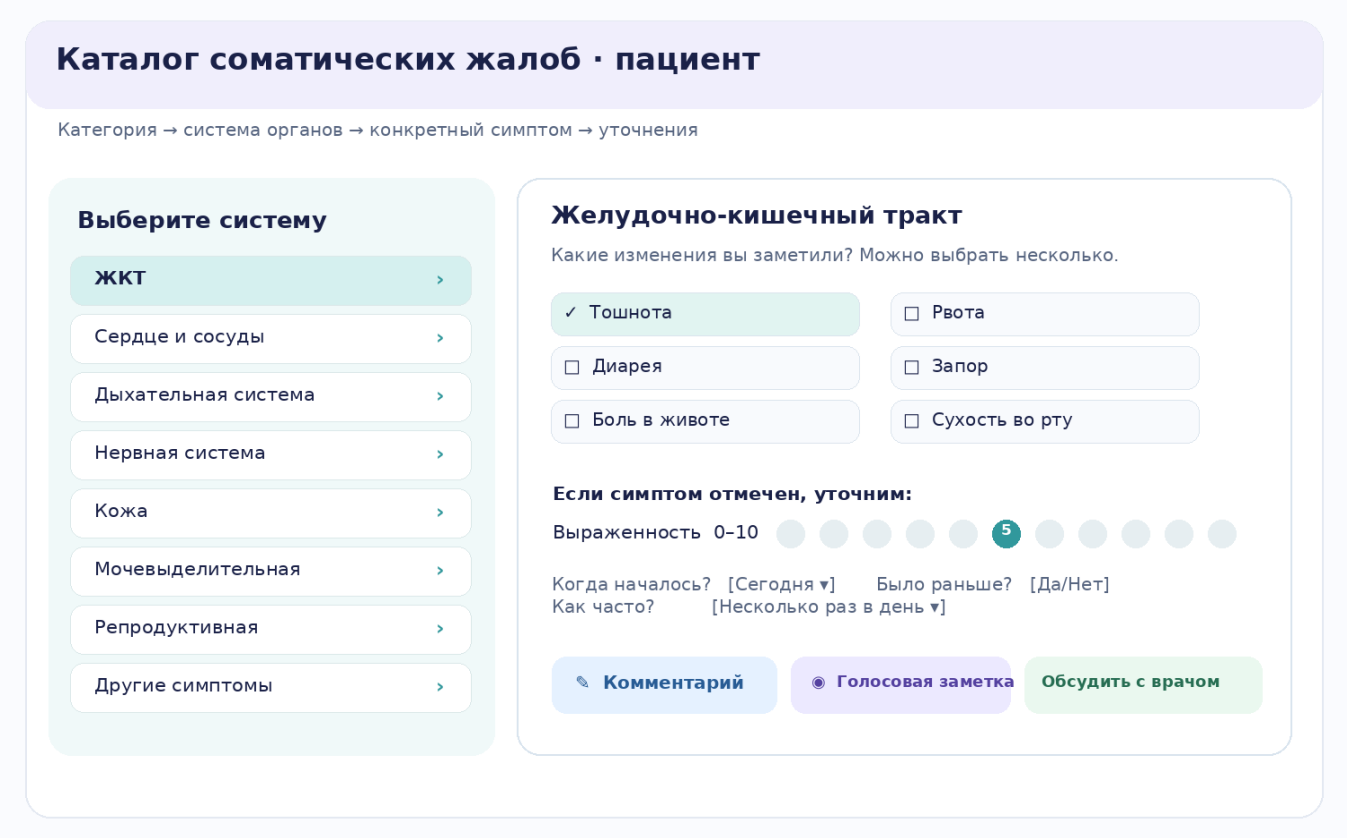
Безопасность и ограничения: Не прятать неизвестную жалобу и не заставлять пациента угадывать медицинский термин.

A.13. Полный маршрут фиксации жалобы

- Старт: открыть «Физическое самочувствие» → систему органов или поиск. К примеру, в ЖКТ выбрать «Тошнота».

- Вопрос 1: «Замечали ли вы этот симптом?» — да / нет / не уверен(а); при «нет» длинную ветку не показывать.
- Если «да»: «Когда началось?», «Было ли до начала лечения?», «Насколько выражено 0–10?», «Как часто?», «Мешает ли повседневным делам?»; периоды и подписи шкал фиксированы.
- По желанию: текст, голосовая заметка, фото/документ и отметка «обсудить с врачом». Сохранённую запись можно исправить, сохранив историю версий.
- Для врача: симптом как событие со ссылкой на оригинал; рядом — даты назначений и изменений терапии. Временное совпадение само по себе не доказывает лекарственную причинность.

Рабочая схема A: пациент выбирает систему органов, затем симптом; текст и голос — рядом с оценкой.



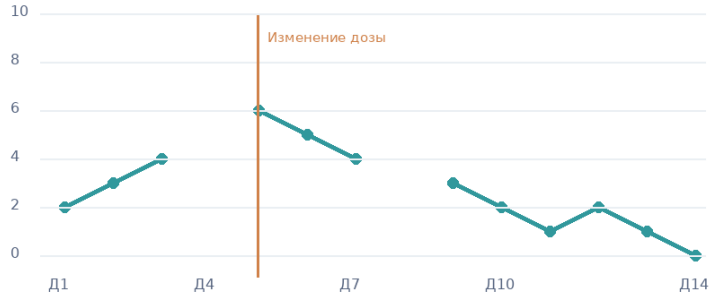
Рабочая схема B: врач видит отдельную временную линию жалобы, изменение терапии и дни без данных.

Специалист: сопоставление соматических симптомов

Нет котов; отдельные оси, события лечения и пропуски показателей.

Пациент · период 14 дней · система: ЖКТ

Тошнота · выраженность 0–10



Ключевые события

2 дня без ответа
Не считать нулём

1 изменение дозы
Отмечено на графике

1 новое сообщение
Пациент приложил голос

3 вопроса к приёму
Есть исходные записи

Комментарий и голосовая заметка привязаны к дате, симптому и автору записи. Красные флаги — по утверждённому протоколу.

Дополнение В. Специализированные клинические модули: подробный экран и график

Следующие 12 модулей основаны на перечне в предоставленном документе. Это проектный дизайн измерений — не валидированные шкалы и не заменитель клинического обследования. Их выбирает и утверждает специалист после клинической оценки; некоторые требуют дополнительных правил безопасности и отдельного согласия. Каждый модуль имеет разделы «Что заполняет пациент», «Что автоматически подсчитывается», «Что увидит специалист».

В.01. Биполярное расстройство

Конкретный показатель	Формат ввода для пациента
Настроение и раздражительность	Отдельные шкалы 0–10 (подписи обязательны), время суток
Сон и потребность во сне	Часы фактического сна + субъективное «меньше сна, но не устал(а)»
Энергия и активность	0–10; изменение количества дел, речи, скорости мыслей
Импульсивность	Отмеченные события: траты, рискованные решения, ссоры; добровольно
Приём назначенных препаратов	Отдельные подтверждённые отметки и пропуски

Пример карточки пациента

«Сколько спали? Было ли ощущение, что сна нужно заметно меньше обычного? Изменилась ли активность?»

Экран врача и график: Отдельные линии сна, энергии и настроения на сопоставимом периоде; события импульсивности отмечены маркерами, а не суммированы в «балл мании».

Клиническое ограничение: Не считать высокое настроение выздоровлением. При сочетании уменьшения сна с активацией требуется утверждённая врачебная логика внимания; диагноз по дневнику не ставится.

Визуальная структура: на главной у пациента — компактная тематическая карточка со статусом «по плану специалиста»; внутри — короткий список вопросов с пропуском и свободным комментарием. У специалиста — исходные значения, отдельные графики и события на временной шкале.

В.02. Паническое расстройство

Конкретный показатель	Формат ввода для пациента
Эпизод приступа	Да/нет/не уверен; дата и время начала
Продолжительность	Минуты, приблизительное значение допустимо
Максимальная тревога	0–10 в момент эпизода
Сопутствующие ощущения	Мультивыбор: сердцебиение, одышка, дрожь и др.
Избегание и страх нового приступа	Событие, субъективная интенсивность 0–10
Контекст и помощь	Где был, что попробовал, текст/голос

Пример карточки пациента

«Был ли приступ резкой сильной тревоги? Сколько продолжался? Чего вы стали избегать после?»

Экран врача и график: Столбцы числа отмеченных приступов за неделю; отдельная линия максимальной тревоги; список контекстов и избегания.

Клиническое ограничение: Возможные соматические неотложные состояния нельзя относить к «панике» автоматически; предусмотрены отдельные красные флаги.

Визуальная структура: на главной у пациента — компактная тематическая карточка со статусом «по плану специалиста»; внутри — короткий список вопросов с пропуском и свободным комментарием. У специалиста — исходные значения, отдельные графики и события на временной шкале.

B.03. Социальная тревожность

Конкретный показатель	Формат ввода для пациента
Ситуация общения	Тип: учёба, работа, разговор, выступление, транспорт, другое
Ожидаемая и фактическая тревога	Две оценки 0–10 с меткой до/после
Избегание	Да/нет/частично; что не получилось
Участие в общении	Минуты/факт действия, без норм по числу контактов
Выполнение согласованного упражнения	Выполнено/частично/не удалось + препятствия

Пример карточки пациента

«Была ли сегодня ситуация, в которой трудно общаться? Удалось ли в ней участвовать?»

Экран врача и график: События социальных ситуаций, тревога до/после; процент выполненных именно назначенных шагов, а не «социальная успешность».

Клиническое ограничение: Не превращать увеличение контактов в обязательную цель без согласия. Экспозиции — по плану специалиста.

Визуальная структура: на главной у пациента — компактная тематическая карточка со статусом «по плану специалиста»; внутри — короткий список вопросов с пропуском и свободным комментарием. У специалиста — исходные значения, отдельные графики и события на временной шкале.

B.04. Обсессивно-компульсивные симптомы

Конкретный показатель	Формат ввода для пациента
Навязчивые мысли	Субъективная частота или минуты за день; без навязывания подробностей содержания
Компульсивные действия	Минуты/день и число эпизодов при необходимости
Дистресс	0–10 с фиксированными подписью и периодом
Влияние на день	Отдельно учёба/работа/сон/отношения по выбору
Работа с терапевтическим заданием	Запланировано/пробовал/трудно + комментарий

Пример карточки пациента

«Сколько времени сегодня заняли навязчивые мысли или повторяющиеся действия?»

Экран врача и график: Две раздельные линии времени на обсессии и компульсии; столбцы выполненных заданий; динамика влияния на жизнь.

Клиническое ограничение: Не выдавать дневник за психотерапию и не превращать внесение данных в дополнительный ритуал/проверку.

Визуальная структура: на главной у пациента — компактная тематическая карточка со статусом «по плану специалиста»; внутри — короткий список вопросов с пропуском и свободным комментарием. У специалиста — исходные значения, отдельные графики и события на временной шкале.

B.05. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

Конкретный показатель	Формат ввода для пациента
Ночные кошмары	Дни/эпизоды, влияние на сон
Непроизвольные воспоминания / флешбэки	Факт и интенсивность; детализация не обязательна
Избегание и гипервозбуждение	Частота/0–10, обстоятельства по желанию
Чувство безопасности	Краткая оценка 0–10 по желанию
Действия стабилизации	Применённый навык и субъективная полезность

Пример карточки пациента

«Были ли сегодня воспоминания или реакции, которые сильно мешали? Можно не описывать их содержание.»

Экран врача и график: Отдельные календари кошмаров и навязчивых воспоминаний; качество сна; изменения функционирования.

Клиническое ограничение: Не требовать подробного пересказа травмы, не принуждать к фиксации триггеров. Вопросы и сроки согласуются с травма-информированным подходом.

Визуальная структура: на главной у пациента — компактная тематическая карточка со статусом «по плану специалиста»; внутри — короткий список вопросов с пропуском и свободным комментарием. У специалиста — исходные значения, отдельные графики и события на временной шкале.

B.06. Расстройства пищевого поведения

Конкретный показатель	Формат ввода для пациента
Регулярность питания	Нейтральная запись о режиме, без оценки «правильно/неправильно»
Аппетит и эмоциональные факторы	Категории изменений и «трудно сказать»
Соматические симптомы	Слабость, головокружение, ЖКТ и т. д. по врачебному плану
Обращения за помощью	Чек-лист шагов и обратная связь
Медицинский контроль	Только назначенные клиницистом параметры/анализы

Пример карточки пациента

«Как прошли приёмы пищи? Что особенно затруднило выполнение согласованного плана?»

Экран врача и график: Нейтральная хронология согласованного режима и симптомы; специализированные медицинские измерения доступны врачу.

Клиническое ограничение: По умолчанию не включать калории, вес, сравнение тела и «достижения похудения»; необходимые измерения врач может скрыть от пациента.

Визуальная структура: на главной у пациента — компактная тематическая карточка со статусом «по плану специалиста»; внутри — короткий список вопросов с пропуском и свободным комментарием. У специалиста — исходные значения, отдельные графики и события на временной шкале.

B.07. Психотические расстройства

Конкретный показатель	Формат ввода для пациента
Сон и изменение режима	Часы и субъективное качество сна
Повседневное функционирование	Учёба/дела/общение с поддержкой и без
Индивидуально согласованные ранние признаки	Описательные нейтральные формулировки, по плану клинициста
Переносимость и приём препаратов	Назначение, статус, жалобы, изменение дозы
Самочувствие и дистресс	0–10 по согласованному вопросу

Пример карточки пациента

«Было ли сегодня сложнее заниматься привычными делами? Есть ли изменение сна или самочувствия?»

Экран врача и график: Раздельные тренды сна, функционирования, нежелательных явлений; список согласованных признаков для обсуждения.

Клиническое ограничение: Не подтверждать и не оспаривать бредовое содержание через автоматический интерфейс; кризисные признаки — по клиническому маршруту.

Визуальная структура: на главной у пациента — компактная тематическая карточка со статусом «по плану специалиста»; внутри — короткий список вопросов с пропуском и свободным комментарием. У специалиста — исходные значения, отдельные графики и события на временной шкале.

B.08. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)

Конкретный показатель	Формат ввода для пациента
Концентрация	Трудности 0–10 на конкретном виде задач
Начало и завершение дел	Число запланированных/завершённых дел, не путать с эффективностью терапии
Организация времени	События опозданий/отвлечений по желанию
Импульсивность	Событийные заметки и влияние на функционирование
Сон/лекарства	По плану специалиста, отдельные модули

Пример карточки пациента

«Удалось ли начать и завершить запланированные дела? Что мешало?»

Экран врача и график: Столбцы задач, отдельная линия субъективной трудности концентрации; календарь сна/лекарств.

Клиническое ограничение: Не измерять личную ценность «продуктивностью». Учитывать контекст, нагрузку и сопутствующие состояния.

Визуальная структура: на главной у пациента — компактная тематическая карточка со статусом «по плану специалиста»; внутри — короткий список вопросов с пропуском и свободным комментарием. У специалиста — исходные значения, отдельные графики и события на временной шкале.

B.09. Хроническая боль

Конкретный показатель	Формат ввода для пациента
Локализация	Выбор области на силуэте тела
Интенсивность	0–10 + описание типа боли
Длительность	Часы/дни и частота эпизодов
Ограничение деятельности	Что не получилось, степень влияния 0–10
Обезболивающее и меры помощи	Факт, время и комментарий; назначение отдельно

Пример карточки пациента

«Где сегодня была боль и насколько она мешала заниматься обычными делами?»

Экран врача и график: Линия боли, отдельная линия влияния на функционирование, аннотации терапии, карта участков тела.

Клиническое ограничение: Острые опасные признаки не должны растворяться в привычной шкале хронической боли.

Визуальная структура: на главной у пациента — компактная тематическая карточка со статусом «по плану специалиста»; внутри — короткий список вопросов с пропуском и свободным комментарием. У специалиста — исходные значения, отдельные графики и события на временной шкале.

B.10. Нарушения сна

Конкретный показатель	Формат ввода для пациента
Отход ко сну и пробуждение	Дата + время, пересечение полуночи
Засыпание / бодрствование ночью	Минуты, число пробуждений
Предполагаемое время сна	Часы/минуты отдельно от времени в постели
Качество и сонливость	Субъективная шкала, закреплённые якоря
Дневной сон / сдвиг режима	Минуты, начало и окончание

Пример карточки пациента

«Во сколько легли? Сколько времени понадобилось, чтобы заснуть? Как отдохнули?»

Экран врача и график: Гипнограмма/временная шкала сна, столбцы продолжительности, линия субъективного качества, пробуждения.

Клиническое ограничение: Не выдавать показания носимых устройств за полисомнографию; при тяжёлых нарушениях — направление к специалисту.

Визуальная структура: на главной у пациента — компактная тематическая карточка со статусом «по плану специалиста»; внутри — короткий список вопросов с пропуском и свободным комментарием. У специалиста — исходные значения, отдельные графики и события на временной шкале.

B.11. Употребление психоактивных веществ

Конкретный показатель	Формат ввода для пациента
Факт и тип употребления	Добровольная запись категории, без моральной оценки
Количество / частота	Единицы, соответствующие конкретному веществу; дата
Тяга	0–10 и ситуации, связанные с желанием употребить
Изменение поведения	Факты и небольшие согласованные цели
Ситуации риска	Выбор категории или комментарий по желанию

Пример карточки пациента

«Хотели бы вы отметить употребление, тягу или сложную ситуацию? Можно пропустить.»

Экран врача и график: Раздельные столбцы частоты, линия тяги, события и достижения индивидуальных целей.

Клиническое ограничение: Сведения особо чувствительны; границы конфиденциальности ясно описаны. Признаки опасной интоксикации или отмены требуют отдельной помощи.

Визуальная структура: на главной у пациента — компактная тематическая карточка со статусом «по плану специалиста»; внутри — короткий список вопросов с пропуском и свободным комментарием. У специалиста — исходные значения, отдельные графики и события на временной шкале.

B.12. Индивидуальное хроническое заболевание

Конкретный показатель	Формат ввода для пациента
Основные симптомы	Список задаётся врачом, с индивидуальными методами
Домашние показатели	Единицы, устройство, условия измерения
Приём назначенных средств	Статусы по каждой схеме
Лабораторные/инструментальные тесты	Дата, результат, референс и файл
Функционирование и цели	0–10 или чек-лист по индивидуальному плану

Пример карточки пациента

«Какие изменения, связанные с вашим заболеванием, были сегодня? Какие данные назначено измерять?»

Экран врача и график: Только назначенные временные ряды и события; контрольные даты обследований; исходное значение отдельно.

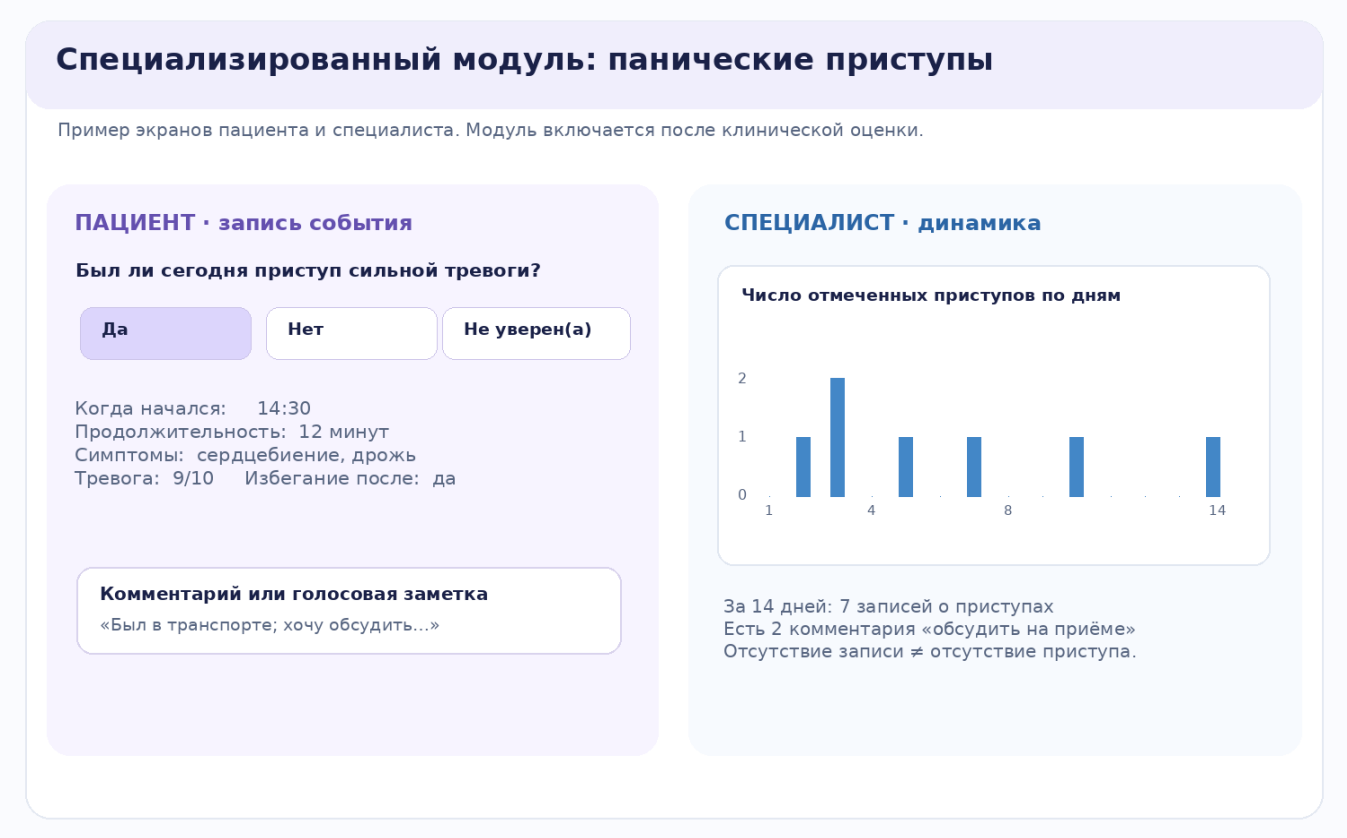
Клиническое ограничение: Нет универсального шаблона частоты и порогов. Нормы и алгоритмы устанавливаются для конкретного заболевания врачом.

Визуальная структура: на главной у пациента — компактная тематическая карточка со статусом «по плану специалиста»; внутри — короткий список вопросов с пропуском и свободным комментарием. У специалиста — исходные значения, отдельные графики и события на временной шкале.

B.13. Пример адаптивного сценария панического приступа

- Стартовая короткая карточка «Был ли сегодня приступ резкой сильной тревоги?» без обязательного раскрытия деталей.
- При ответе «да» последовательно открываются дата/время, продолжительность в минутах, выраженность 0–10, симптомы и влияние на дальнейшие действия.
- Опционально: отметить избегание, описать своими словами, прикрепить голосовую запись и поставить флаг «хочу обсудить».
- Специалист видит число подтверждённых записей, распределение по дням, тяжесть каждого эпизода и наличие пропусков данных. Это не самостоятельный диагноз.

Схема C. Пациентская запись события и отдельный профессиональный просмотр того же модуля.



Дополнение C. Графики — подробная спецификация для всех основных категорий

Любой график содержит заголовок, период, единицу измерения, подписанные оси и разъяснение «источник данных». Врач может открыть конкретную точку и увидеть оригинальный ответ, дату, автора, комментарий, файл, версию шкалы. Незаполненные дни не соединяются искусственной интерполяцией. Не сравнивать разные инструменты на общей вертикальной шкале без явного разграничения.

Общее самочувствие

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Самооценка 0–10	Линия: X дата, Y 0–10; рядом события-комментарии	7/14/30 дней; дата каждой записи

Эмоции и настроение

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Настроение, тревога, энергия — независимые шкалы	Несколько линий с явной легендой и одинаковыми якорями; эмоции — частотная диаграмма отдельно	Линии при наличии одинакового recall-периода

Сон и биоритмы

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Продолжительность и субъективное качество сна	Столбцы часов/минут; линия качества 1–5 на другом графике; временная лента начала/конца	Ночь привязывается к дате пробуждения по правилу продукта

Активность

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Минуты, шаги и выполненные конкретные дела	Столбцы минут/шагов; чек-лист активных дней; показатели целей отдельно	Не смешивать шаги, минуты и «баллы активности»

Когнитивные функции

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Концентрация и затраты времени на трудности	Линия 0–10; столбцы минут для отдельных симптомов	Только один и тот же вопрос и интервал

Медикаментозная терапия

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Отмеченные фактические приёмы и события	Календарь статусов доз; вертикальные метки назначений и изменений доз; симптомы по отдельной оси	Нет ответа не равно пропуску

Антропометрия

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Масса, окружности; вычисляемый ИМТ	Точки по датам измерения, с единицами; ИМТ и масса на отдельных графиках	Нет «зелёной/красной оценки» по весу

Физиологические показатели

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
АД, пульс, температура и другие назначенные	Отдельные линейные графики с единицами, источником и датой; лабораторные результаты — точки	Для детского возраста и разных методик разные нормы

Питание и вода

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Аппетит, регулярность, кофеин, вода	Линия аппетита 0–10; столбцы числа приёмов пищи; мл воды и кофеин — отдельно	Не подставлять универсальную цель по воде

Соматическое самочувствие

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Конкретные симптомы по системам	Линия интенсивности, столбцы эпизодов, карта локализации и временная шкала событий	Оси строго под конкретный симптом

Психотерапия и события

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Согласованные задания и события	Календарь выполнения; линия полезности навыка (0–10) отдельно	Частота заданий не показатель «хорошего пациента»

Менструальный цикл

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Начало и конец кровотечения, боль, изменения настроения	Календарь дат, линия боли, события кровотечений; настроение рядом при согласии	Не определять фазу овуляции по календарю как факт

Витамины и БАДы

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Подтверждённые дозы и переносимость	Календарь приёма по каждой добавке; симптомные события по датам	Отсутствие приёма не равно лабораторному дефициту

Индивидуальные цели

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Оценки конкретных целей 0–10	Отдельная линия каждой цели с исходной и текущей оценкой	Не «процент выздоровления»

Клинические шкалы

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
PHQ-9, GAD-7, ISI, WSAS и другие	Каждая методика — отдельная диаграмма по датам тестирования; баллы и диапазон	Не рисовать ежедневные значения шкалы, если её не проходили

Материалы и рекомендации

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Статусы отдельных назначений	Список статусов, число выполненных из назначенных, хронология трудностей	Не оценивать эффективность терапии по одному %

Подготовка к консультации

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Вопросы и сохранённые события	Список с датами, приоритетами и связями с конкретными графиками	Не график «качества пациента»

Специализированные клинические модули

Показатели	Тип графика и оси	Что важно показать
Уникальные показатели для каждого расстройства	Отдельные серии, определённые в разделе B; никогда универсальная сумма «всего»	У каждого шаблона своя версия и проверка

C.19. Правила отображения графиков

Элемент	Точное поведение
Временная ось	День/неделя/месяц; точки по фактической дате; локальный часовой пояс; выбор периода 7/14/30/90 дней или календарный.
Ось значений	Оригинальные единицы; абсолютные баллы с якорями. Не нормализовать GAD-7 к 0–10 без валидированного метода.
Пропущенные дни	Разрыв линии, прозрачный маркер «нет данных». Ноль рисуется только при явном нулевом ответе.
Препараты и вмешательства	Вертикальная аннотация даты начала/изменения дозы; без вывода, что терапия вызвала изменение графика.
Наведённая точка / нажатие	Дата, значение, исходный вопрос, единица, комментарий, источник, статус исправления, связанные события.
Подсказки трендов	Формулировать «среднее изменилось на 2 пункта за 7 дней», а не «расстройство уменьшилось на 30%».
Экспорт	PDF-отчёт с периодом, легендой, пропусками, временем генерации и ролью пользователя.

Дополнение D. Автоматические расчёты, формулы и ограничения

Все производные значения маркируются «рассчитано автоматически», сохраняют исходные данные, формулу, единицы и дату. Система не заменяет врачебную интерпретацию. Если хотя бы одно обязательное значение отсутствует, результат — «недостаточно данных», а не 0.

ИМТ взрослого

Расчёт: масса_кг / (рост_м × рост_м). Пример: 64 кг и 1,60 м → 25,0 кг/м²; правильная реализация — кг / (м × м). Условия: Использовать только при известном росте и массе; не диагностировать по одному ИМТ; возраст до 18 лет — иная интерпретация

Изменение массы

Расчёт: последняя масса − исходная масса. Пример: 64,0 − 65,0 = −1,0 кг. Условия: Только сопоставимые измерения; % = (текущая − исходная)/исходная × 100

Продолжительность сна

Расчёт: время пробуждения − время засыпания, с переходом суток. Пример: 23:30–07:00 → 7 ч 30 мин. Условия: Нужен ввод предполагаемого сна, ночного бодрствования; дата и часовой пояс

Частота событий

Расчёт: Число реально отмеченных событий за заданный период. Пример: 3 за неделю. Условия: «Не отмечено» не означает, что события точно не происходили

Изменение шкалы

Расчёт: последнее подтверждённое значение − исходное. Пример: GAD-7 15 → 9: изменение −6 баллов. Условия: Одинаковая версия, одинаковый временной интервал; шкалы не усреднять с EMA

Индивидуальная цель

Расчёт: новое GBO − исходное GBO. Пример: 2/10 → 6/10: +4 пункта. Условия: Одна и та же цель, подписанные значения; не показатель ремиссии

Заполненность

Расчёт: количество назначенных заполненных/количество назначенных пунктов ×100%. Пример: 11/14 дней = 78,6%. Условия: Не использовать как оценку дисциплины, не смешивать с приёмом лекарств

Подтверждённый приём

Расчёт: подтверждённые принятые дозы / ожидаемые дозы с известным статусом. Пример: Только при валидных подтверждениях. Условия: Неизвестные статусы — отдельно; не утверждать приём без ответа

День менструального цикла

Расчёт: дата записи − дата 1-го дня последней менструации +1. Пример: Из даты начала можно получить день N. Условия: Не считать точной овуляцией, не прогнозировать беременность по календарю

Длина цикла

Расчёт: разность дат первого дня двух последовательных менструаций. Пример: 28 дней — пример. Условия: Не оценивать «нормальность» без врачебного контекста; нужны ≥2 даты начала

Исправление формулы ИМТ

Корректная формула строго: **ИМТ = масса (кг) / [рост (м)]²**. Для роста 160 см сначала перевести в 1,60 м. Пример: 64 / (1,60 × 1,60) = 25,0 кг/м². Никаких пересчётов по миллиметрам или умножения метров на 1000.

Схема D. Отдельный ввод антропометрии, нейтральный силуэт и расчёт ИМТ; справа — профессиональный график без котов.



Дополнение E. Текст, голос, файлы и взаимодействие с врачом

Функция	Пациент	Специалист / логика
Текстовый комментарий	Свободный ответ к любому выбранному пункту; можно написать без числовой оценки.	Показывать дословный оригинал, дату, автора, к какому показателю привязан.
Голосовое сообщение	Кнопка «Записать», понятная длительность, прослушать, удалить/перезаписать, отправить.	Оригинальная аудиодорожка и при согласии редактируемая расшифровка; не считать транскрипт диагнозом.
Файл / фотография	Добровольное вложение к конкретной жалобе; перед загрузкой подсказка о чувствительности фото.	Доступ по ролям, аудит обращений, удаление, ограничения формата/размера, запрет публичной выдачи URL.
«Обсудить на приёме»	Флажок независимо от наличия комментария. Можно выбрать приоритет и отменить.	Отдельный список вопросов, сортировка по дате, связи с событиями и графиками.
Пропустить / не помню	Необязательный вопрос можно отложить, сохранить черновик, выбрать «не уверен(а)».	Статус в данных отличен от «нет», «ноль» и подтверждённого пропуска терапии.
Конфиденциальность	Отдельное информированное согласие для чувствительных сведений и вложений.	Нужны прозрачные полномочия, журнал доступа, сроки хранения и механизм удаления.

E.1. Как комментарии выглядят на графике

Рядом с точкой записи показать маленький значок комментария или микрофона. Нажатие открывает карточку с датой, числовым значением, дословной заметкой и кнопкой «связано с вопросом на консультацию». Медицинские пометки врача отделены от слов пациента; автоматическая расшифровка, если она используется, должна быть помечена как машинная и допускает исправление.

E.2. Запреты и важные границы

- Никакая запись пациента не обязана автоматически попадать в круглосуточно контролируемый врачом канал. Указать реальные сроки просмотра и границы связи.
- Нельзя заставлять человека прикреплять интимные фотографии или объяснять травматический опыт, чтобы завершить дневник.
- Нельзя создавать диагноз из частоты нажатий, эмоций или машинной расшифровки голоса.
- Кризисные сообщения и потенциально опасные симптомы — отдельный утверждённый алгоритм маршрутизации, без котов и нейтральных «спасибо».
- Назначения медикаментов доступны для изменения только уполномоченному врачу; данные пациента о приёме не меняют схему лечения.

Дополнение F. Критерии готовности экранов к разработке

Экран	Критерий приёмки
Пациент / главная	Показывает лишь активные модули; котик только в небольшой зоне прогресса/необязательном уведомлении; «пропустить» заметно.
Пациент / система органов	Два шага выбора: система, затем конкретный симптом; поиск по синонимам, выбранные эффекты сохраняются.
Пациент / клинический модуль	Есть объяснение назначения врачом; не показывает диагноз как автоматический вывод; формы короткие и контекстные.
Пациент / запись	Каждое поле имеет единицы/подписи, историю, комментарий, голос, файл и флаг обсуждения.
Пациент / антропометрия	Силуэт без лица; ИМТ рассчитывается при наличии двух значений, есть оговорка о детях/спецконтексте.
Врач / главная	Белый профессиональный интерфейс, без котов, разделяет исходные клинические шкалы и ежедневные самооценки.
Врач / графики	Нулевые значения не подставляются вместо пропусков; доступ к первичной записи, событиям лечения и версии вопроса.
Врач / конструктор	Шаблон → категория → показатель → частота → триггер → обязательность → права → просмотр глазами пациента → сохранить.
Библиотека уведомлений	Исходные 59 сообщений сохранены полностью; в роли врача никакой маскот, исключена серия упрёков за незаполнение.
Безопасность	Весь функционал до реального клинического применения утверждается медицинскими экспертами, а правила конфиденциальности проверены юристами.

11. Библиотека уведомлений — все 59 исходных вариантов

Этот раздел намеренно содержит всю предоставленную тобой библиотеку, без сокращения до «примеров». Для реализации нужно сохранить заголовок и подзаголовок как отдельные поля. Конкретное сообщение показывается только если релевантный модуль включён. По умолчанию уведомления можно отложить, пропустить или отключить.

В пользовательском списке используется дружеское обращение «ты». В медицинской версии нужно на уровне профиля выбрать единый стиль обращения («ты» или «вы»), согласовать склонения и не смешивать их в одном интерфейсе. Тексты ниже приведены в исходной редакции.

01. Общие вопросы о самочувствии

Заголовок уведомления	Подзаголовок / поддерживающий текст
Как проходит твой день?	Если хочется, расскажи в двух словах.
Как ты сегодня?	Можно выбрать короткий ответ или рассказать подробнее.
Есть минутка для себя?	Как ты себя чувствуешь прямо сейчас?
Что было самым заметным сегодня?	Событие, мысль или чувство — выбирай сам.
Небольшая пауза.	Что сейчас хотелось бы отметить?
Как проходит вечер?	Если хочется, сохрани короткую запись о дне.

02. Эмоции и настроение

Заголовок уведомления	Подзаголовок / поддерживающий текст
Что сейчас чувствуешь?	Можно выбрать эмоцию или написать своими словами.
Какое у тебя сегодня настроение?	Отметь его на привычной шкале.
Были ли сегодня сильные эмоции?	Если хочется, расскажи, что их вызвало.
Настроение менялось в течение дня?	Это можно отметить коротко, без объяснений.
Как сегодня ощущалась тревога?	Выбери число или пропусти вопрос.
Был ли момент спокойствия?	Если да, можешь его отметить.

03. Сон и восстановление

Заголовок уведомления	Подзаголовок / поддерживающий текст
Как прошла ночь?	Отметь сон, если он есть в твоём плане наблюдения.
Как тебе спалось?	Можно указать продолжительность и качество сна.
Удалось отдохнуть?	Как чувствуешь себя после сна?
Как сегодня с энергией?	Оцени уровень сил по привычной шкале.

Заголовок уведомления	Подзаголовок / поддерживающий текст
Заметил изменения сна?	Можно сохранить запись для следующей консультации.
Как проходит вечер?	Хочешь отметить состояние перед сном?

04. Активность и личные достижения

Заголовок уведомления	Подзаголовок / поддерживающий текст
Даже маленький шаг считается!	Что сегодня удалось сделать?
Что сегодня получилось?	Необязательно что-то большое.
Как идут твои цели?	Отметь то, что удалось сделать сегодня.
Удалось уделить время себе?	Можно отметить любое приятное занятие.
Было ли что-то приятное?	Если хочется, сохрани этот момент.
Что хотелось бы повторить завтра?	Одна небольшая идея — уже достаточно.

05. Напоминания о незаполненных пунктах

Заголовок уведомления	Подзаголовок / поддерживающий текст
Осталось всего два вопроса!	Можешь закончить сейчас или вернуться позже.
Есть незаполненные пункты.	Посмотри, что осталось на сегодня.
Маленький чек-ин?	Даже короткая запись поможет сохранить историю изменений.
Не хочется писать?	Можно выбрать готовый ответ или вернуться позже.
Запись можно продолжить.	Твои предыдущие ответы уже сохранены.
Сегодня ещё не отмечен сон.	Если удобно, дополни эту часть дневника.
Один пункт остался без ответа.	Можно заполнить, пропустить или отложить.
Сегодня не до дневника?	Можно вернуться, когда будет удобнее.

06. Лечение и побочные эффекты

Заголовок уведомления	Подзаголовок / поддерживающий текст
Время отметки о препарате.	Укажи, был ли приём по назначенной схеме.
Приём сегодня уже отмечен?	Можно записать его сейчас или позже.
Как переносится лечение?	Есть ли новые или изменившиеся ощущения?
Заметил нежелательные симптомы?	Сохрани их для обсуждения со специалистом.
Что-то мешает соблюдать назначения?	Можно кратко отметить причину.
Остались вопросы о лечении?	Запиши их к следующей консультации.

07. Физическое самочувствие

Заголовок уведомления	Подзаголовок / поддерживающий текст
Как чувствует себя тело?	Есть ли боль, напряжение или другие ощущения?
Как самочувствие сегодня?	Можно выбрать из списка или написать вручную.
Есть новые симптомы?	Если да, отметь, когда они появились.
Как изменился уровень усталости?	Если отслеживаешь его, оцени по привычной шкале.
Есть что обсудить о самочувствии?	Можно оставить комментарий специалисту.

08. Прогресс и графики

Заголовок уведомления	Подзаголовок / поддерживающий текст
Твоя неделя в дневнике.	Можно посмотреть, как менялись выбранные показатели.
Есть новые данные для сравнения.	Открой динамику сна, настроения и активности.
Что изменилось за последние дни?	Графики помогут заметить закономерности.
Есть движение к твоей цели.	Посмотри, какие шаги уже отмечены.
Появился недельный обзор.	Изменения и пропуски собраны в одном месте.
Есть что обсудить на приёме?	Выбери важные события из истории дневника.

09. Подготовка к консультации

Заголовок уведомления	Подзаголовок / поддерживающий текст
Есть что-то важное для специалиста?	Можно написать или записать голосовое сообщение.
Что хотелось бы обсудить?	Сохрани вопрос, чтобы не забыть на консультации.
Было ли что-то необычное?	Можно отметить событие и его дату.
Скоро консультация.	Можно посмотреть записи и выбрать важное.
Хочешь дополнить дневник?	Свободная заметка тоже может быть полезной.

10. После заполнения

Заголовок уведомления	Подзаголовок / поддерживающий текст
Запись на сегодня сохранена!	Спасибо, что поделился.
На сегодня всё.	К дневнику можно вернуться в любой момент.
Все выбранные пункты заполнены!	Теперь можно посмотреть общую динамику.
Спасибо за запись.	Твои ответы доступны в истории дневника.
Готово!	Важные детали можно будет обсудить со специалистом.

12. Событие → реакция приложения

Событие	Как реагирует приложение
Наступило удобное пациенту время	Ненавязчивый вопрос о самочувствии.
Заполнена часть дневника	Показывает, сколько вопросов осталось.
Пациент не хочет отвечать	Предлагает пропустить или отложить.
Запланирован приём препарата	Напоминание согласно действующей схеме.
Пришло время повторной шкалы	Предлагает пройти назначенный опросник.
Накопились данные за неделю	Предлагает посмотреть графики.
Приближается консультация	Помогает подготовить вопросы.
Пациент закончил заполнение	Показывает случайный стикер с котом.

Дополнительные правила диспетчера уведомлений

- Не отправлять уведомление по выключенному модулю или уже завершённому пункту; учитывать часовой пояс и тихие часы.
- Препарат: текст на заблокированном экране должен быть нейтральным, без чувствительного названия; действия открываются после авторизации.
- Повторные шкалы: запускать только по плану врача; длинные опросники не отправлять ежедневно по умолчанию.
- После пропуска вопроса не упрекать, не накапливать «долги» и не использовать наказательные серии.
- Важные медицинские предупреждения должны быть без котов и без шуточного оформления; уведомление не заменяет маршрут экстренной помощи.
- Не создавать дубли сообщений: ограничить частоту, позволить выбрать время и канал, давать «отложить» и «отключить».
- Котики подбираются случайно только на пациентских карточках общих, прогрессных и завершённых действий. Врачебная панель и медицинские красные флаги — без маскота.

13. Правила визуального языка

Элемент	Правило
Цвет категории	Последовательный мягкий цвет, но не клиническая оценка и не единственный способ различения.
Основные пациентские карточки	Прямоугольные, округлённые, достаточно свободные, с последним значением и датой.
Коты	Редко: один небольшой стикер в зоне прогресса, некоторые необязательные напоминания; не в каждой категории.
Врачебные экраны	Никаких котов. Белый фон, спокойные нейтральные акценты, клинические графики и источники данных.
Антропометрия	Нейтральный силуэт без лица, предпочтительно схематичный контур тела.
Чувствительные разделы	Менструации, сексуальные симптомы, интимные фото — нейтральная пиктограмма, без котов и шуток.
Доступность	Достаточный контраст, текстовые подписи, крупные элементы ввода, режим без декора.

14. Минимальный объём демоверсии (MVP)

- «Окно доверия» и персонализация с согласованием специалистом.
- Библиотека примерно 12 основных модулей с включением, отключением и выбором индивидуальной частоты.
- Две самостоятельные главные страницы — пациентская и врачебная.
- Короткий ежедневный чек-ин + сохранение черновика, пропуск, свободный комментарий.
- Приём одного назначенного лекарства, нейтральное напоминание и адаптивный вопрос о симптоме.
- Базовый сон, настроение, тревога, энергия, цель, питание и факультативный цикл.
- Библиотека рекомендаций: одно видео, одна статья и одно упражнение с обратной связью.
- Недельный/14-дневный график и консультационное резюме с корректными пропусками.
- Все 10 групп уведомлений как готовая текстовая библиотека, без обязательной отправки всех сообщений.
- Правила безопасности, конфиденциальности и ролей до демонстрации на реальных пациентах.

Сквозной сценарий демонстрации

- 1. Пациент видит «Окно доверия», выбирает темы и одну персональную цель.
- 2. Специалист открывает библиотеку, собирает дневник и утверждает 5 коротких ежедневных пунктов.
- 3. Пациент открывает главный экран, отвечает на вопрос о настроении и отмечает ночной сон.
- 4. В календаре отмечает препарат; при новом симптоме выбирает его из каталога, оставляет голосовое сообщение и флаг «обсудить».
- 5. Специалист назначает статью или упражнение; пациент отвечает «частично выполнил, было трудно».
- 6. На врачебной странице открывается 14-дневная динамика, даты с отсутствующими данными и список вопросов к приёму.

Критерий успешной демоверсии

Разработчик может показать путь пациента и путь специалиста отдельно: настройка → одна запись → персонализированный симптом → материал → отчёт. Нельзя демонстрировать автономное назначение лекарств или автоматическую диагностику как работающую клиническую функцию.

15. Иллюстративные макеты — как их использовать

Далее помещены четыре ранее созданных визуальных примера: (1) пациентская главная страница, (2) отдельный экран специалиста, (3) библиотека модулей, (4) библиотека уведомлений. Это эстетические ориентиры для Figma и разработки, а не точные интерфейсные спецификации. Текст настоящего ТЗ имеет приоритет при расхождении с надписями внутри изображений.

Изображения содержат демонстрационные показатели и условные сведения. В частности, день менструального цикла нельзя автоматически считать определённой фазой. Календарь в макете не подтверждает овуляцию. Клинические пороги/сигналы и наименования лекарств из примеров требуют отдельной проверки до реального использования.

Визуальный пример А. Пациентская главная страница с умеренным количеством котиков.



Визуальный пример В. Профессиональный экран специалиста без котов.



Визуальный пример С. Каталог модулей и источники персонализации.



Визуальный пример D. Пациентская библиотека уведомлений и правила тона.



16. Список проверок перед передачей в разработку

- У каждого показателя есть тип ответа, подписи шкал, единицы, дата, версия и частота.
- Пациентская и врачебная главные страницы разведены физически и логически; котов в кабинете специалиста нет.
- Чувствительные поля и файлы управляются отдельными разрешениями; на экране блокировки нет раскрытия диагноза.
- Нет данных не равно 0; неизвестно не равно отрицательному ответу; незаполненная отметка не считается пропуском дозы.
- При включении лекарственного модуля симптомы спрашиваются индивидуально и всегда допускают свободное описание.
- Питание не сводится к калориям и «правильности»; цикл не обязателен для всех.
- Клинические шкалы отделены от EMA-дневника; сравнительные графики используют сопоставимые измерения.
- Специалист видит исходную запись и историю назначений; пациент может помечать вопросы к приёму.
- Присутствуют все 59 исходных текстов 10 групп уведомлений, действия «позже» и «пропустить».
- Отчёты показывают динамику и вопросы, а не диагноз или процент выздоровления.
- Все клинические предупреждения утверждаются специалистом; для экстренных ситуаций есть отдельные маршруты.
- Доступность: текстовые подписи, контраст, клавиатурное управление и режим без декоративных элементов.

Основа документа и статус

Составлено на основе предоставленных материалов: (1) «Клинический компас — дневник-конструктор», DOCX, 11 страниц; (2) «Концепция персонализированного конструктора дневника пациента и системы мониторинга эффективности лечения», TXT; (3) полный текст библиотеки уведомлений из этого чата; (4) предоставленные скриншоты, листы котов и ранее сгенерированные четыре макета. Разделы о безопасности, дозировании частоты и пользовательских правах сформулированы как продуктовые требования для дальнейшей клинической и юридической верификации.

Отдельной верификации потребуют официальные клинические рекомендации, лицензирование шкал, правила для ПО — медицинского изделия, алгоритмы красных флагов, права на распространение сторонних изображений и научное обоснование автоматического ранжирования лекарств. Не использовать документ как медицинскую инструкцию для назначения препаратов.